

Banco de cuestiones de Microbiología II

Versión V4.28 - 472 preguntas - gabarito simple y visible

Índice interactivo

Virología

1. Generalidades de Virología - 21 preguntas
2. Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8 - 45 preguntas
3. Papilomavirus - 33 preguntas
4. Adenovirus - 31 preguntas
5. Parvovirus y Poxvirus - 38 preguntas
6. Picornavirus - 34 preguntas
7. Orthomixovirus y Reovirus - 33 preguntas
8. Paramixovirus - 36 preguntas
9. Rhabdovirus - 30 preguntas
10. Togavirus y Flavivirus - 30 preguntas
11. Retrovirus - 31 preguntas

Parasitología

12. Generalidades, huéspedes y prevención - 10 preguntas
13. Paludismo - 10 preguntas
14. Trypanosoma - 10 preguntas
15. Toxoplasma gondii - 10 preguntas
16. Leishmania - 10 preguntas
17. Protozoarios intestinales y urogenitales - 10 preguntas
18. Nematodos intestinales - 10 preguntas
19. Cestodos - 10 preguntas
20. Trematodos - 10 preguntas

Artrópodos

21. Artrópodos de importancia médica - 10 preguntas

Serpientes

22. Importancia médica de serpientes - 10 preguntas

Gabarito al final: letra correcta y texto de la alternativa correcta, organizado por bloque.

1. Generalidades de Virología

Virología · 21 preguntas · Fuente: UNIDAD 1 - Generalidades (1).pdf

1. Un alumno afirma que un virus clínicamente importante puede llevar ADN y ARN al mismo tiempo. Según las generalidades de virología, cuál corrección es la más adecuada?

- A) Puede llevar ambos si posee envoltura lipídica.
- B) Puede llevar ambos durante la fase de eclipse.
- C) Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos.
- D) El ARN aparece solo en virus de cápside desnuda.
- E) El ADN aparece solo en virus con simetría helicoidal.

2. Si un virion conserva infectividad después de desecación, ácido gástrico y detergentes, que rasgo estructural lo explica mejor?

- A) Cápside desnuda proteica.
- B) Envoltura con glucoproteínas.
- C) Genoma segmentado.
- D) Transcriptasa inversa.
- E) Simetría compleja.

3. En un esquema básico, capsómeros de polipeptidos que rodean el ácido nucleico forman la cápside. Como se denomina el conjunto cápside más ácido nucleico?

- A) Envoltura viral.
- B) Peplómero viral.
- C) Cuerpo de inclusión.
- D) Viroplasma.
- E) Nucleocápside.

4. Durante el diagnóstico de una infección viral aguda, se busca detectar directamente material genético del virus. Qué técnica corresponde mejor a ese objetivo?

- A) Prueba de coagulasa.
- B) PCR o RT-PCR.
- C) Prueba de ureasa.
- D) Coprocultivo bacteriano.
- E) Tinción de Gram.

5. La envoltura viral suele relacionarse con una mayor fragilidad ambiental. Qué consecuencia práctica se espera?

- A) Mayor resistencia a bilis.
- B) Mayor tolerancia a desecación.
- C) Mayor estabilidad en aguas residuales.
- D) Mayor sensibilidad a detergentes.
- E) Mayor resistencia a pH ácido.

6. Un virus causa enfermedad por destruir células durante su replicación. Qué término general describe mejor ese efecto?

- A) Citólisis viral.
- B) Latencia antigénica.
- C) Tolerancia humoral.
- D) Recombinación bacteriana.
- E) Antagonismo fúngico.

7. ¿Cuál combinación relaciona mejor estructura y conducta biológica viral?

- A) Envoltura - resistencia extrema a ácido.
- B) Cápside desnuda - mayor fragilidad ambiental.
- C) Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.
- D) ARN - imposibilidad de variación genética.
- E) ADN - transmisión solo vectorial.

8. Si un virus no produce energía por sí mismo y necesita maquinaria celular, que propiedad está siendo destacada?

- A) Es una célula procariota atípica.
- B) Es un hongo intracelular facultativo.
- C) Es una bacteria sin pared celular.
- D) Es un protozoo con metabolismo reducido.
- E) Es un parásito intracelular obligado.

9. En la secuencia general de replicación, que evento ocurre después de la unión/penetración y antes de la síntesis de nuevos componentes?

- A) Formación de anticuerpos IgG.
- B) Liberación del genoma viral.
- C) Eliminación renal del virión.
- D) Producción de exotoxinas.
- E) Encapsulación por eosinófilos.

10. Un informe integra transmisión respiratoria, fecal-oral, sexual, vectorial y zoonótica. ¿Qué enfoque del curso resume mejor esa lista?

- A) Fases morfológicas de protozoarios.
- B) Tipos de inmunidad bacteriana.
- C) Etapas de esporulación fungica.
- D) Vías epidemiológicas de virus estudiados.
- E) Clases de antibióticos betalactámicos.

11. ¿Cuál es una característica fundamental de los genomas víricos según su composición de ácidos nucleicos?

- A) Contienen ADN o ARN, pero no ambos tipos de ácido nucleico.
- B) Carecen de ácido nucleico y se replican mediante proteínas estructurales.
- C) Pueden contener tanto ADN como ARN en una misma partícula.
- D) El genoma siempre es una cadena doble de ADN circular.

12. ¿Qué unidad de medida se utiliza habitualmente para determinar el tamaño de un virión?

- A) Nanómetros (nm)
- B) Micrómetros (μm)
- C) Milímetros (mm)
- D) Angstroms ($\text{\AA}$)

13. Se define como nucleocápside a la estructura formada por:

- A) La envoltura lipídica y las glucoproteínas externas.
- B) El conjunto de capsómeros antes de unirse al genoma.
- C) La membrana plasmática de la célula que rodea al virus.
- D) El ácido nucleico asociado a la cápside proteica.

14. ¿En qué lugar de la célula hospedadora ocurre generalmente la replicación de los virus ADN?

- A) Núcleo
- B) Retículo endoplásmico
- C) Aparato de Golgi
- D) Citoplasma

15. ¿Qué término describe el periodo en el que un virus está presente en el cuerpo pero en estado de reposo, sin multiplicarse ni producir síntomas?

- A) Infección lítica
- B) Periodo de eclipse
- C) Periodo de latencia
- D) Fase prodrómica

16. En el contexto de la citopatogenia, una infección transformadora se caracteriza por:

- A) La replicación viral continua a niveles muy bajos sin matar la célula.
- B) El fracaso total de la entrada del virus a la célula diana.
- C) La muerte rápida de la célula por lisis.
- D) La integración o persistencia del virus que induce una proliferación celular descontrolada.

17. ¿Cuál es el mecanismo de liberación más común para los virus que poseen envoltura?

- A) Difusión simple
- B) Lisis celular
- C) Gemación
- D) Endocitosis inversa

18. ¿Qué familia de virus posee un genoma de ARN segmentado y causa la gripe?

- A) Picornaviridae
- B) Coronaviridae
- C) Retroviridae
- D) Orthomyxoviridae

19. ¿Cuál de las siguientes técnicas se considera el estándar actual para detectar genomas de ARN viral?

- A) Hibridación in situ (FISH)
- B) Microscopía electrónica
- C) RT-PCR (PCR con transcriptasa inversa)
- D) PCR convencional

20. ¿Cuál de estos virus es un ejemplo de virus ADN con cápside desnuda (sin envoltura)?

- A) Herpesvirus
- B) Adenovirus
- C) Hepadnavirus
- D) Poxvirus

21. Los síntomas iniciales e inespecíficos como fiebre, cefalea o dolor corporal que preceden a los síntomas graves se denominan:

- A) Recidiva
- B) Viremia
- C) Pródromos
- D) Resolución

2. Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8

Virología · bloque combinado · Herpes simple, varicela-zóster, VEB, CMV y otros herpesvirus. · 45 preguntas

1. Una paciente presenta lesiones vesiculares recurrentes en la misma zona. Qué propiedad del VHS explica mejor estas recurrencias?

- A) Latencia en ganglios sensoriales.
- B) Mutación diaria de la cápside.
- C) Eliminación completa del genoma.
- D) Replicación exclusiva en eritrocitos.
- E) Resistencia por cápside desnuda.

2. Para iniciar una infección por VHS, que condición de entrada es más coherente con su patogenia?

- A) Eritrocito maduro intacto.
- B) Hepatocito sin receptor.
- C) Hueso cortical compacto.
- D) Cartilago articular sano.
- E) Piel o mucosa lesionada.

3. En la replicación de herpes simple, las proteínas beta se relacionan principalmente con:

- A) Ensamble tardío de cápside.
- B) Replicación del ADN viral.
- C) Bloqueo de la fusión celular.
- D) Formación de ooquistes.
- E) Maduración en mosquito.

4. Un niño desarrolla varicela y años después herpes zoster.Cuál secuencia biológica es la más correcta?

- A) Infección intestinal, quiste y excistación.
- B) Bacteriemia primaria, endospora y toxina.
- C) Viremia nula, eliminación total y reinfección.
- D) Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.
- E) Vectorización, esporozoito y merozoito.

5. El virus varicela-zoster comparte con los herpesvirus la capacidad de:

- A) Establecer infección persistente de por vida.
- B) Vivir libremente fuera de células.
- C) Formar huevos en heces humanas.
- D) Replicarse solo en citoplasma sin núcleo.
- E) Tener ARN segmentado negativo.

6. Un paciente inmunodeprimido con VHS tiene riesgo aumentado de cuadros graves porque estos virus:

- A) Nunca reactivan en inmunidad normal.
- B) Son siempre benignos en todo hospedador.
- C) Pueden producir morbilidad significativa.
- D) No inducen infección latente.
- E) Carecen de tropismo tisular.

7. Qué hallazgo citológico apoya una infección por herpesvirus, aunque no distingue con precisión el tipo viral?

- A) Huevos mamelonados.
- B) Larvas filariformes.
- C) Quistes con cuatro núcleos.
- D) Eritrocitos parasitados en anillo.
- E) Celulas gigantes multinucleadas.

8. En herpes simple, la zona de latencia más característica corresponde a:

- A) Macrófagos esplénicos.
- B) Neurona de ganglio sensorial.
- C) Hepatocito periportal.
- D) Eritroblasto medular.
- E) Queratinocito cornificado.

9.Cuál afirmación compara mejor VHS-1 y VHS-2?

- A) No comparten ADN ni antígenos.
- B) Ambos son virus ARN envueltos.
- C) Solo VHS-2 puede permanecer latente.
- D) Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.
- E) Solo VHS-1 se replica en núcleo.

10. En una sospecha de encefalitis herpética, la herramienta diagnóstica directa más útil para LCR suele ser:

- A) Hemocultivo anaerobio.
- B) Cinta adhesiva perianal.
- C) PCR para ADN viral.
- D) Gota gruesa de malaria.
- E) Búsqueda de huevos operculados.

11. Un adolescente con fiebre, faringitis, adenopatías y linfocitos atípicos tuvo contacto íntimo por saliva. Qué virus encaja mejor?

- A) Citomegalovirus.
- B) Virus herpes humano 8.
- C) Adenovirus entérico.
- D) Parvovirus B19.
- E) Virus Epstein-Barr.

12. La mononucleosis infecciosa por VEB se interpreta como resultado principalmente de:

- A) Lisis de eritrocitos por toxina preformada.
- B) Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados.
- C) Migración larvaria hacia pulmón.
- D) Destrucción directa de hepatocitos por ooquistes.
- E) Replicación viral exclusiva en neutrófilos.

13. En VEB, qué célula es clave como diana y zona de latencia?

- A) Eritrocito maduro.
- B) Neurona motora.
- C) Miocito esquelético.
- D) Linfocito B.
- E) Célula parietal gástrica.

14. Un paciente inmunodeficiente con VEB presenta riesgo especial de:

- A) Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.
- B) Tos ferina y bronquiolitis neonatal.
- C) Larva migrans ocular por nematodo.
- D) Hidatidosis hepática multivesicular.
- E) Anemia por uncinarias.

15. Qué cuadro se asocia con VHH-6/VHH-7 en la infancia?

- A) Rabia furiosa.
- B) Condiloma acuminado.
- C) Exantema subit.
- D) Fiebre amarilla urbana.
- E) Parálisis flácida poliomielítica.

16. La asociación clínica más característica de VHH-8 es:

- A) Eritema infeccioso.
- B) Panencefalitis esclerosante.
- C) Gastroenteritis por rotavirus.
- D) Quiste hidatídico.
- E) Sarcoma de Kaposi.

17. CMV congénito debe sospecharse con mayor atención cuando existe:

- A) Ingestión de pescado crudo con B12 baja.
- B) Infección materna y daño fetal compatible.
- C) Mordedura de perro con hidrofobia.
- D) Prurito anal nocturno familiar.
- E) Piodermatitis por estreptococo.

18. En CMV, que hallazgo histológico clásico orienta el diagnóstico?

- A) Huevos con espina lateral.
- B) Trofozoitos con eritrocitos ingeridos.
- C) Capsídeo desnudo en forma de bala.
- D) Inclusiones intranucleares en ojo de buho.
- E) Larvas en cinta adhesiva.

19. Una mononucleosis con anticuerpos heterófilos negativos puede relacionarse con:

- A) Rabdovirus.
- B) Dengue primario.
- C) Citomegalovirus.
- D) Fasciola hepática.
- E) Taenia saginata.

20. ¿Cuál combinación es más correcta?

- A) VEB - saliva - linfocito B.
- B) CMV - mosquito - hepatocito exclusivo.
- C) VHH-8 - agua - enterocito.
- D) VHH-6 - carne cruda - músculo.
- E) VEB - garrapata - eritrocito.

21. ¿Cuál es el sitio primario de latencia para el Virus de Epstein-Barr (VEB) según la fisiopatología descrita?

- A) Células epiteliales de la bucofaringe
- B) Monocitos
- C) Linfocitos T protectores
- D) Linfocitos B

22. En el contexto de la patogenia del VEB, ¿qué fenómeno explica la aparición de la mononucleosis infecciosa?

- A) La lisis directa de todas las células epiteliales infectadas
- B) Una respuesta inmunitaria hiperactiva de los linfocitos T
- C) Una respuesta inmunitaria ausente o ineficaz
- D) La producción exclusiva de anticuerpos heterófilos

23. ¿Qué característica morfológica define a las células de Downey observadas en frotis citológicos de pacientes con mononucleosis?

- A) Células epiteliales con aspecto veloso en la cavidad bucal
- B) Cuerpos de inclusión basófilos en forma de 'ojo de búho'
- C) Linfocitos T con citoplasma basófilo y vacuolado con núcleo ovalado
- D) Linfocitos B monoclonales con mandíbula deformada

24. ¿Cuál es la tríada clásica de síntomas que presenta un paciente con mononucleosis infecciosa?

- A) Linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa
- B) Fiebre súbita, convulsiones y exantema generalizado
- C) Microcefalia, ictericia y calcificación intracerebral
- D) Fatiga crónica, cefalea y diarrea persistente

25. En pacientes con SIDA, ¿cuál es la manifestación oportunista del VEB que afecta específicamente a las células epiteliales de la boca?

- A) Leucoplasia vellosa oral
- B) Linfoma de Burkitt
- C) Retinitis por VEB
- D) Carcinoma nasofaríngeo

26. ¿Cuál es el principal vector o vía de transmisión del Citomegalovirus (CMV) mencionado como el más relevante?

- A) Saliva
- B) Aerosoles respiratorios
- C) Semen
- D) Lágrimas

27. ¿Qué hallazgo histológico es patognomónico de la infección por CMV y constituye su efecto citopatológico (ECP)?

- A) Células epiteliales con inclusiones intracitoplasmáticas filamentosas
- B) Célula citomegálica con cuerpo de inclusión intranuclear en 'ojo de búho'
- C) Presencia de linfocitos de Downey
- D) Linfocitos B policlonales en proliferación

28. ¿Cuál es la causa vírica más frecuente de anomalías congénitas según el material de estudio?

- A) Virus de la Malaria
- B) Citomegalovirus (CMV)
- C) Virus Herpes Humano 6 (VHH-6)
- D) Virus de Epstein-Barr (VEB)

29. ¿En qué tipo de células establece su latencia el Citomegalovirus (CMV)?

- A) Células epiteliales y endoteliales
- B) Monocitos y linfocitos
- C) Linfocitos B únicamente
- D) Neuronas sensoriales

30. En recién nacidos prematuros, ¿cuál es el riesgo principal tras recibir transfusiones de sangre contaminadas con CMV?

- A) Neumonía y hepatitis
- B) Convulsiones febriles
- C) Pérdida auditiva bilateral
- D) Sarcoma de Kaposi

31. La roséola o exantema súbito es causada por la infección de qué virus específicos?

- A) VHS-1 y VHS-2
- B) VHH-8 únicamente
- C) VHH-6B y VHH-7
- D) VEB y CMV

32. ¿Qué síntoma es un factor de 'atención' importante en la infección por VHH-6 durante la infancia (6-24 meses)?

- A) Linfoma africano
- B) Rotura del bazo
- C) Ceguera por retinitis
- D) Convulsiones febriles

33. ¿Cómo se describe el exantema característico de la roséola súbita?

- A) Vesículas dolorosas en dermatomas específicos
- B) Exudado blanquecino en la faringe con fatiga extrema
- C) Pápulas umbilicadas que pican intensamente
- D) Llagas pequeñas ligeramente elevadas de color rosa sin prurito

34. ¿Cuál es la recomendación preventiva para la mononucleosis en cuanto al contacto con el virus en etapas tempranas de la vida?

- A) Aislamiento total de los niños para evitar la infección latente
- B) Vacunación obligatoria antes de los 2 años
- C) Favorecer el contacto temprano ya que la enfermedad es benigna o subclínica en niños
- D) Administración de ganciclovir profiláctico en guarderías

35. En el diagnóstico de laboratorio para mononucleosis, ¿qué técnica se reserva exclusivamente para casos graves?

- A) Aislamiento viral en cultivo
- B) Prueba de anticuerpos heterófilos
- C) Citología de linfocitos atípicos
- D) Sondas de ADN y PCR

36. ¿Cuál es la principal complicación neurológica mencionada que puede surgir de una mononucleosis infecciosa?

- A) Retraso mental profundo
- B) Síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis
- C) Sordera unilateral
- D) Convulsiones febriles

37. Respecto al Linfoma de Burkitt, ¿en qué población geográfica y bajo qué condición coadyuvante es endémico?

- A) Niños en África con malaria
- B) Pacientes con SIDA en Europa
- C) Neonatos en América con CMV
- D) Adultos en Asia con carcinoma nasofaríngeo

38. Si un paciente con mononucleosis presenta síntomas por más de 4 semanas, ¿cómo se clasifica el cuadro?

- A) Enfermedad linfoproliferativa mortal
- B) Recidiva latente
- C) Cuadro crónico
- D) Infección lítica aguda

39. ¿Cuál es la diferencia principal entre la infección primaria y la recidiva de CMV durante el embarazo?

- A) Ambas tienen el mismo riesgo de malformaciones
- B) Solo la recidiva se transmite por vía ascendente
- C) La infección primaria es extremadamente grave para el feto
- D) La recidiva siempre causa microcefalia

40. ¿Qué secreción corporal se identifica como la vía de transmisión para el VHH-6 y VHH-7?

- A) Leche materna únicamente
- B) Sangre y derivados
- C) Orina y lágrimas
- D) Secreciones bucales (saliva y aerosoles)

41. ¿En qué grupo de pacientes el CMV causa frecuentemente esofagitis y colitis?

- A) Ancianos con mononucleosis
- B) Mujeres embarazadas seropositivas
- C) Niños sanos en edad escolar
- D) Pacientes con SIDA

42. ¿Qué porcentaje de adultos suele tener presente el VHH-6 en su saliva?

- A) La mayoría de los adultos
- B) Solo aquellos que trabajan en hospitales
- C) Menos del 10%
- D) Únicamente adultos con SIDA

43. En el diagnóstico diferencial, ¿qué distingue a la mononucleosis por CMV de la causada por VEB?

- A) El CMV no causa fiebre ni fatiga
- B) La mononucleosis por CMV es negativa a anticuerpos heterófilos
- C) El VEB no produce linfocitosis
- D) Solo el VEB se transmite por la saliva

44. Respecto a las enfermedades linfoproliferativas por VEB, ¿qué ocurre en sujetos que carecen totalmente de inmunidad celular?

- A) Desarrollan inmunidad natural permanente sin síntomas
- B) Pueden padecer una enfermedad policlonal de linfocitos B potencialmente mortal
- C) El virus no puede infectarlos al no haber linfocitos T
- D) Sufren únicamente de faringitis leve recurrente

45. ¿Cuál es la principal forma de prevenir la transmisión de la mononucleosis infecciosa?

- A) Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes y vasos
- B) Uso de mascarillas N95 en lugares públicos
- C) Tratamiento profiláctico con aciclovir a toda la población
- D) Vacunarse anualmente durante la adolescencia

3. Papilomavirus

Virología · 33 preguntas · Fuente: Unidad 3 Papilomavirus.pdf

1. La estructura que mejor describe al HPV es:

- A) ARN segmentado con envoltura.
- B) ADN circular bicatenario sin envoltura.
- C) ARN negativo helicoidal con envoltura.
- D) ADN monocatenario envuelto.
- E) ARN bicatenario con doble cápside.

2. Un virus que infecta queratinocitos del estrato espinoso y produce verrugas corresponde mejor a:

- A) Rotavirus.
- B) Rabdovirus.
- C) Citomegalovirus.
- D) Papilomavirus humano.
- E) Plasmodium.

3. La latencia local del HPV se relaciona principalmente con:

- A) Queratinocito infectado.
- B) Neurona de ganglio dorsal.
- C) Linfocito B de memoria.
- D) Eritroblasto medular.
- E) Hepatocito periportal.

4. Qué asociación entre genotipo y riesgo clínico es más adecuada?

- A) HPV 6/11 - alto riesgo cervical.
- B) HPV 1 - sarcoma de Kaposi.
- C) HPV 16/18 - cáncer cervical.
- D) HPV 2 - encefalitis necrosante.
- E) HPV 5 - paludismo grave.

5. En relación con los VPH de alto riesgo, especialmente VPH-16 y VPH-18, ¿cuál consecuencia clínica se asocia mejor según la fuente?

- A) Verrugas plantares benignas sin relación cervical.
- B) Sarcoma de Kaposi en inmunodeprimidos.
- C) Displasia, neoplasia cervical y cáncer de cuello uterino.
- D) Bronquiolitis grave en lactantes pequeños.
- E) Hidrofobia con encefalitis progresiva.

6. Un condiloma acuminado genital se asocia con más frecuencia a:

- A) Adenovirus urinario.
- B) HPV mucoso de bajo riesgo.
- C) Virus de la rabia.
- D) Toxoplasma tisular.
- E) Diphyllbothrium.

7.Cuál vía de adquisición es más coherente con HPV mucoso genital?

- A) Inhalación en cuevas.
- B) Picadura de Anopheles.
- C) Ingestión de berro acuático.
- D) Contacto sexual directo.
- E) Mordedura de perro.

8. Una razón por la cuál la infección por HPV puede persistir es que:

- A) El virus destruye siempre todo el epitelio basal en horas.
- B) El virus no infecta células humanas.
- C) La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.
- D) La replicación ocurre solo en eritrocitos circulantes.
- E) La cápside tiene envoltura muy frágil.

9. El método preventivo más relevante frente a lesiones malignas asociadas a HPV es:

- A) Vacunación contra tipos oncogénicos.
- B) Suero antifúngico polivalente.
- C) Cloración única del agua.
- D) Quimioprofilaxis antimalaria universal.
- E) Cinta adhesiva perianal.

10. En una prueba de tamizaje cervical, el hallazgo que hace pensar en infección por HPV es:

- A) Cuerpos de Negri.
- B) Células falciformes.
- C) Huevos mamelonados.
- D) Amastigotes en macrofagos.
- E) Koilocitosis.

11. ¿Cuál es la conformación estructural del genoma de los papilomavirus humanos?

- A) ADN lineal monocatenario
- B) ADN circular bicatenario
- C) ARN circular bicatenario
- D) ADN lineal bicatenario

12. ¿En qué capa específica de la piel se produce principalmente la replicación activa del VPH?

- A) Estrato córneo
- B) Hipodermis
- C) Estrato espinoso
- D) Dermis

13. En el diagnóstico citológico, ¿qué término describe a los queratinocitos infectados con cambios citopáticos como el citoplasma vacuolado?

- A) Células de Langerhans
- B) Células de Merkel
- C) Koilocitos
- D) Melanocitos

14. ¿Qué genotipos de VPH están más frecuentemente asociados con papilomas laríngeos y verrugas anogenitales benignas?

- A) VPH-6 y VPH-11
- B) VPH-1 y VPH-4
- C) VPH-31 y VPH-45
- D) VPH-16 y VPH-18

15. ¿Cuál es el método de elección para confirmar el genotipo específico de una infección por VPH?

- A) Inmunofluorescencia directa
- B) Citología (Papanicolaou)
- C) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
- D) Cultivo vírico

16. ¿Qué porcentaje aproximado de las neoplasias cervicales a nivel mundial se asocian a la presencia de VPH?

- A) 30,0%
- B) 50,0%
- C) 70,0%
- D) 99,7%

17. En el contexto de la patogénesis del VPH, ¿cómo se define una neoplasia?

- A) Crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales
- B) Infección lítica sin proliferación celular
- C) Paso previo a una alteración de la función celular
- D) Resolución espontánea de una verruga

18. ¿Cuál es la recomendación de frecuencia para el tamizaje con Papanicolaou (PAP) en una mujer con resultados previos negativos?

- A) Anual
- B) Una sola vez en la vida
- C) Cada 5 años
- D) Cada 6 meses

19. Sobre la vacuna contra el VPH, ¿cuál es una limitación fundamental mencionada en el material?

- A) No puede tratar ni curar una infección ya existente
- B) Es ineficaz si se administra antes de los 9 años
- C) Requiere una dosis única para protección de por vida
- D) Solo protege contra un único serotipo viral

20. ¿Qué factor de riesgo conductual se menciona como agravante para la progresión de la infección por VPH hacia el cáncer?

- A) Tabaquismo
- B) Dieta alta en grasas
- C) Consumo de alcohol
- D) Sedentarismo

21. ¿Cómo se conoce vulgarmente a las verrugas plantares causadas frecuentemente por el VPH?

- A) Melanoma
- B) Ojo de gallo
- C) Condiloma
- D) Pápula

22. ¿Qué tipos de VPH son responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo?

- A) VPH-1 y VPH-2
- B) VPH-16 y VPH-18
- C) VPH-6 y VPH-11
- D) VPH-31 y VPH-33

23. En el desarrollo de la enfermedad por VPH, ¿qué ocurre durante la etapa de latencia?

- A) El sistema inmunitario elimina completamente el genoma viral del organismo
- B) El virus permanece en los queratinocitos sin producir síntomas visibles
- C) El virus se replica masivamente destruyendo el estrato basal
- D) Las células infectadas se transforman inmediatamente en células cancerosas

24. Además del contacto sexual, ¿qué otra vía de transmisión directa es común para las verrugas cutáneas?

- A) Picadura de insectos
- B) Transmisión aérea (gotitas)
- C) Ingesta de alimentos contaminados
- D) Autoinoculación

25. ¿Por qué los papilomas laríngeos representan un riesgo de muerte en la población pediátrica?

- A) Posible obstrucción de las vías respiratorias
- B) Destrucción total de las cuerdas vocales por necrosis
- C) Inducción de fallo renal agudo
- D) Metástasis rápida hacia el cerebro

26. ¿Cuál es la efectividad reportada de los preservativos para reducir el riesgo de contagio del VPH?

- A) 30 al 60%
- B) 100%
- C) Menos del 5%
- D) 90 al 95%

27. ¿Qué característica morfológica define microscópicamente a una verruga?

- A) Hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis
- B) Atrofia del estrato basal con pérdida de melanina
- C) Destrucción de los capsómeros de los queratinocitos
- D) Infiltrado masivo de neutrófilos en la dermis papilar

28. ¿Cuál es el período de incubación (P.I.) típico para la aparición de verrugas comunes?

- A) 10 a 15 años
- B) 24 a 48 horas
- C) Hasta 3 o 4 meses
- D) Exactamente una semana

29. En la clasificación por localización, ¿cómo se agrupan los VPH?

- A) Aeróbicos o anaeróbicos
- B) Cutáneos o mucosos
- C) Agudos o fulminantes
- D) Sistémicos o localizados

30. ¿Qué tipos de cáncer son más frecuentes en hombres debido a la infección por VPH?

- A) Cáncer de próstata y vejiga
- B) Cáncer de pene, ano y orofaringe
- C) Cáncer de testículo
- D) Cáncer de pulmón y estómago

31. ¿Cuál es la principal razón por la que se recomienda extirpar las verrugas, a pesar de que pueden remitir espontáneamente?

- A) Para evitar el dolor, motivos estéticos y prevenir la autoinoculación
- B) Porque siempre se transforman en tumores malignos si no se quitan
- C) Para permitir que la vacuna funcione después de la cirugía
- D) Para eliminar el reservorio de ARN viral de la sangre

32. ¿Qué factor inmunológico explica que las verrugas desaparezcan por sí solas en muchos casos?

- A) La interferencia del virus JC que compite por la célula
- B) El agotamiento natural de los capsómeros virales
- C) La falta de queratina en el estrato espinoso
- D) La respuesta inmunitaria del hospedador

33. En el frotis de Papanicolaou, ¿qué significa el hallazgo de una Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) de grado 2?

- A) Tejido completamente normal
- B) Displasia moderada
- C) Cáncer invasivo con metástasis
- D) Infección viral resuelta

4. Adenovirus

Virología · 31 preguntas · Fuente: Unidad 4.1 Adenovirus.pdf

1. La descripción estructural más correcta para adenovirus es:

- A) ARN negativo segmentado, con envoltura.
- B) ADN monocatenario circular, con envoltura.
- C) ARN bicatenario, cápside helicoidal.
- D) ADN bicatenario lineal, sin envoltura.
- E) ARN positivo, sin cápside.

2. Los principales antígenos de adenovirus se relacionan con:

- A) Hexonas, pentonas y fibras.
- B) HA, NA y proteína M2.
- C) E1, E2 y proteína NS1.
- D) Gp120, gp41 e integrasa.
- E) Esporozoito, merozoito y gametocito.

3. La replicación del ADN adenoviral ocurre principalmente en:

- A) Mitocondria.
- B) Citoplasma libre.
- C) Nucleo celular.
- D) Ribosoma bacteriano.
- E) Vacuola digestiva.

4. Una infección por adenovirus puede comprometer respiratorio, digestivo, urinario y ojo. ¿Qué cuadro ocular es compatible?

- A) Catarata congénita.
- B) Uveítis toxoplásmica obligatoria.
- C) Retinopatía hipertensiva.
- D) Glaucoma agudo.
- E) Conjuntivitis.

5. Si se observan cuerpos de inclusión nuclear con acumulación de ADN y partículas defectuosas, el dato encaja con:

- A) Trypanosoma.
- B) Adenovirus.
- C) Strongyloides.
- D) Fasciola.
- E) Echinococcus.

6. A diferencia de varios virus envueltos, los adenovirus son relevantes en brotes porque:

- A) Mueren rápidamente fuera del hospedador.
- B) Solo infectan por vía sexual.
- C) No se liberan nunca por lisis.
- D) Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.
- E) No se transmiten entre humanos.

7. ¿Qué afirmación sobre oncogenicidad es la más fiel al material?

- A) Todos causan cáncer cervical humano.
- B) Solo producen sarcoma de Kaposi.
- C) Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos.
- D) Son oncogénicos solo por mosquitos.
- E) Transforman eritrocitos maduros.

8. La liberación del adenovirus desde la célula infectada se produce principalmente por:

- A) Lisis celular.
- B) Gemación apical permanente.
- C) Exocitosis de ooquistes.
- D) Salida por huevo embrionado.
- E) Fagocitosis inversa.

9. Una infección latente por adenovirus puede persistir en:

- A) Eritrocitos circulantes.
- B) Ganglios sensitivos exclusivamente.
- C) Macrófagos hepáticos obligados.
- D) Neumocitos sin núcleo.
- E) Células linfoides y adenoides.

10. En una epidemia de faringoconjuntivitis con piscina y conjuntivitis, ¿qué dato apoya adenovirus?

- A) Protozoo flagelado transmitido por vinchuca.
- B) Virus ADN sin envoltura resistente.
- C) Helminto con caracol intermediario.
- D) Virus ARN con transcriptasa inversa.
- E) Cestodo por pescado crudo.

11. ¿En qué tipo de cultivo celular se identificaron originalmente los adenovirus, lo que dio lugar a su nombre?

- A) Células de adenoides
- B) Linfocitos T CD4+
- C) Células epiteliales conjuntivales
- D) Enterocitos del intestino delgado

12. ¿Cuál es la configuración estructural característica del genoma de los adenovirus?

- A) ADN monocatenario lineal
- B) ADN bicatenario circular
- C) ARN monocatenario de sentido positivo
- D) ADN bicatenario lineal

13. ¿En qué compartimento celular tiene lugar la replicación del ADN vírico de los adenovirus?

- A) Citoplasma
- B) Ribosomas
- C) Retículo endoplásmico
- D) Núcleo

14. ¿Qué componentes estructurales constituyen los principales antígenos de los adenovirus?

- A) Polimerasa de ADN y helicasa
- B) Hexonas, pentonas y fibras
- C) Glucoproteínas de envoltura
- D) Proteína de matriz y nucleocápside

15. ¿Cuál es la causa histológica de la formación de cuerpos de inclusión nuclear en células infectadas por adenovirus?

- A) Fusión de membranas celulares para formar sincitios
- B) Aumento masivo del tamaño celular (citomegalia)
- C) Degradación del nucleolo por enzimas víricas
- D) Procesos de replicación y ensamblaje ineficaces

16. ¿Qué tipo de infección establecen los adenovirus en las células linfoides y adenoides?

- A) Infección lítica
- B) Infección latente
- C) Infección transformadora
- D) Infección persistente productiva

17. Respecto a la inmunidad contra los adenovirus, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La inmunidad humoral es el único mecanismo para evitar la proliferación viral
- B) Los anticuerpos no confieren protección contra serotipos diferentes al de la infección original
- C) La infección previa garantiza inmunidad permanente contra todas las enfermedades respiratorias virales
- D) Existe protección cruzada universal entre los 52 serotipos humanos

18. ¿Qué característica de los adenovirus les permite transmitirse a través de piscinas con cloración inadecuada?

- A) Presencia de una envoltura lipídica protectora
- B) Termolabilidad extrema que favorece el contagio en agua templada
- C) Resistencia a la desecación, detergentes y cloro leve
- D) Capacidad de replicación en ambientes acuáticos salinos

19. ¿Cuáles son los serotipos de adenovirus más frecuentemente asociados con infecciones pediátricas de las vías respiratorias?

- A) Tipos 1, 2, 5 y 6
- B) Tipos 40 y 41
- C) Tipos 8, 19 y 37
- D) Tipos 4, 7 y 21

20. ¿Qué serotipos de adenovirus se propagan con mayor facilidad en entornos militares debido al hacinamiento y estilo de vida riguroso?

- A) Tipos 1 y 2
- B) Tipos 11 y 21
- C) Tipos 40 y 41
- D) Tipos 4 y 7

21. Un paciente presenta la tríada de faringitis, conjuntivitis y fiebre. ¿Qué cuadro clínico es el más probable?

- A) Síndrome de tipo tos ferina
- B) Fiebre faringoconjuntival
- C) Enfermedad respiratoria aguda
- D) Queratoconjuntivitis epidémica

22. ¿Cuál es la principal diferencia clínica entre la conjuntivitis y la queratoconjuntivitis por adenovirus?

- A) La presencia de fiebre en la conjuntivitis
- B) La edad del paciente, afectando la queratoconjuntivitis solo a lactantes
- C) La vía de transmisión, que es solo fecal-oral en la conjuntivitis
- D) La presencia de dolor en la queratoconjuntivitis

23. ¿Qué serotipos de adenovirus se clasifican en el grupo F y son responsables de diarrea en lactantes?

- A) Serotipos 3, 4 y 7
- B) Serotipos 40 y 41
- C) Serotipos 11 y 21
- D) Serotipos 1, 2 y 5

24. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación clínica de los adenovirus en el aparato urinario?

- A) Insuficiencia renal aguda obstructiva
- B) Cistitis hemorrágica aguda
- C) Sepsis urinaria por Gram negativos
- D) Glomerulonefritis post-infecciosa

25. ¿Cómo se realiza el diagnóstico definitivo de la infección por adenovirus en el laboratorio?

- A) Cultivo en agar sangre y chocolate
- B) PCR y análisis de sondas de ADN
- C) Observación macroscópica de las secreciones
- D) Prueba de la tuberculina (PPD)

26. En cuanto al tratamiento de las infecciones por adenovirus, ¿cuál es la recomendación actual?

- A) No existe un tratamiento específico aprobado
- B) Uso de antibióticos de amplio espectro de forma profiláctica
- C) Terapia de reemplazo enzimático nuclear
- D) Administración inmediata de aciclovir oral

27. ¿Qué medida de prevención es fundamental para controlar la propagación de adenovirus en instalaciones recreativas?

- A) Cloración adecuada de las piscinas
- B) Vacunación universal de la población civil
- C) Uso de mascarillas N95 en todas las áreas
- D) Hervir el agua de las piscinas antes de cada uso

28. ¿Para qué población está disponible la vacuna oral contra los tipos 4 y 7 de adenovirus?

- A) Adultos mayores inmunodeprimidos
- B) Personal militar
- C) Lactantes y niños pequeños
- D) Pacientes con cáncer de colon

29. ¿Cuál es un uso terapéutico moderno de los adenovirus mencionado en el material?

- A) Desinfección de superficies hospitalarias
- B) Tratamiento antibiótico para la tuberculosis
- C) Vectores para vacunas contra el Ebola y Covid-19
- D) Producción de insulina recombinante en el páncreas

30. ¿En qué momento se inicia la transcripción genética tardía durante el ciclo de replicación de los adenovirus?

- A) Antes de que se sintetice la polimerasa de ADN
- B) Inmediatamente después de la entrada del virus a la célula
- C) Cuando ha finalizado la replicación del ADN
- D) Simultáneamente con la lisis celular

31. ¿Cómo se liberan los viriones de adenovirus de la célula infectada?

- A) Exocitosis mediante vesículas de transporte
- B) Paso directo a través de poros nucleares
- C) Lisis celular
- D) Gemación a través de la membrana plasmática

5. Parvovirus y Poxvirus

Virología · 38 preguntas · Fuente: Unidad 4.2 PARVOVIRUS Y POXVIRUS.pdf

1. Parvovirus B19 se distingue estructuralmente porque es:

- A) ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.
- B) ARN segmentado negativo, envuelto.
- C) ADN bicatenario gigante, envuelto.
- D) ARN positivo helicoidal, sin cápside.
- E) ADN circular con transcriptasa inversa.

2. El tropismo central del parvovirus B19 explica que destruya principalmente:

- A) Neurona de ganglio dorsal.
- B) Hepatocito adulto.
- C) Células precursoras eritroides.
- D) Queratinocito cornificado.
- E) Enterocito ciliado.

3. Un paciente con anemia hemolítica crónica desarrolla aplasia transitoria intensa. Qué virus debe considerarse?

- A) Adenovirus ocular.
- B) Virus rubéola.
- C) VHH-8.
- D) Rinovirus.
- E) Parvovirus B19.

4. En la evolución bifásica por B19, el exantema y la artralgia suelen ser:

- A) Fase de máxima contagiosidad respiratoria.
- B) Mediados por respuesta inmunitaria.
- C) Debidos a larvas pulmonares.
- D) Secuela de infección por poxvirus.
- E) Resultado de huevos en bilis.

5. Durante la primera fase de B19, la contagiosidad se relaciona con:

- A) Quistes en heces formadas.
- B) Metacercarias en vegetales.
- C) Mordedura de murciélago.
- D) Viremia y secreciones respiratorias.
- E) Proglotides en heces.

6. En embarazada, B19 preocupa porque puede provocar:

- A) Condiloma acuminado fetal.
- B) Hidrofobia neonatal.
- C) Hidropesía fetal por anemia.
- D) Megacolon congénito.
- E) Quiste hidatídico pulmonar.

7. Una diferencia importante de poxvirus frente a muchos virus ADN es que:

- A) Replica en el citoplasma.
- B) No posee ningún genoma.
- C) Necesita eritrocitos maduros.
- D) Es siempre no envuelto.
- E) Solo se transmite por alimentos.

8. Los poxvirus se reconocen como virus:

- A) Pequeños, desnudos y de ARN positivo.
- B) Helicoidales en forma de bala.
- C) Segmentados con neuraminidasa.
- D) Flagelados con cinetoplasto.
- E) Grandes, complejos y de ADN bicatenario.

9. La vacuna histórica que permitió controlar la viruela se relaciona con:

- A) Rotavirus.
- B) Vaccinia.
- C) VEB.
- D) Toxoplasma.
- E) Schistosoma.

10. Molluscum contagiosum se debe ubicar dentro del grupo de:

- A) Parvovirus.
- B) Flavivirus.
- C) Cestodos.
- D) Poxvirus.
- E) Trematodos.

11. ¿Cuál es la característica estructural distintiva que define a los parvovirus dentro de los virus de ADN?

- A) Su replicación es exclusivamente citoplasmática.
- B) Presentan una cápside icosaédrica con envoltura lipídica.
- C) Poseen un genoma de ADN bicatenario circular.
- D) Son los virus de ADN de menor tamaño y poseen ADN monocatenario lineal.

12. Durante el ciclo de replicación del parvovirus B19, ¿qué paso es indispensable para que ocurra la transcripción y replicación del genoma vírico?

- A) La integración del genoma vírico en el ADN celular.
- B) La formación de un intermediario de ARN de polaridad negativa.
- C) La salida del núcleo hacia el citoplasma para el ensamblaje del virión.
- D) La síntesis de una cadena complementaria para formar ADN bicatenario.

13. En la evolución bifásica de la infección por B19, ¿cuál es el evento fisiopatológico central de la primera fase (fase febril)?

- A) La aparición del exantema en 'mejilla abofeteada' por inmunocomplejos.
- B) El desarrollo de poliartritis crónica en pacientes pediátricos.
- C) La producción masiva de anticuerpos IgG específicos.
- D) Una intensa viremia y la destrucción lítica de precursores eritroides.

14. ¿Por qué un paciente con eritema infeccioso (quinta enfermedad) ya no se considera contagioso al momento de aparecer el exantema?

- A) Porque el exantema es una manifestación inmunológica posterior a la viremia.
- B) Porque el descenso de la hemoglobina impide la replicación viral.
- C) Porque el virus ha mutado a una forma no patógena.
- D) Porque el virus solo se transmite a través de las costras del exantema.

15. En adultos infectados por parvovirus B19, ¿cuál es la manifestación clínica que predomina sobre el exantema cutáneo?

- A) Crisis aplásica aguda de forma universal.
- B) Bronquiolitis grave y dificultad respiratoria.
- C) Formación de nódulos umbilicados en los genitales.
- D) Poliartritis y artralgias que pueden durar semanas o meses.

16. ¿Cuál es la complicación más grave de la infección por parvovirus B19 en pacientes con anemia hemolítica crónica?

- A) Desarrollo de malformaciones congénitas cardíacas.
- B) Crisis aplásica debida al agotamiento de precursores eritrocitarios.
- C) Insuficiencia hepática fulminante por viremia secundaria.
- D) Eritema infeccioso recidivante.

17. ¿Qué riesgo enfrentan las mujeres embarazadas seronegativas ante una infección por parvovirus B19?

- A) Ninguno, ya que el virus no atraviesa la placenta.
- B) Desarrollo inmediato de molusco contagioso gestacional.
- C) Riesgo de muerte fetal por anemia e insuficiencia cardíaca (hidropesía fetal).
- D) Transmisión de inmunidad pasiva al feto sin riesgos asociados.

18. ¿Cuál es la principal diferencia epidemiológica entre el parvovirus B19 y el bocavirus?

- A) El B19 afecta a animales domésticos y el bocavirus solo a humanos.
- B) El B19 tiene vacuna disponible y el bocavirus no.
- C) El bocavirus se asocia con enfermedades respiratorias y se transmite también por las heces.
- D) El B19 es un virus de ARN y el bocavirus es de ADN.

19. Respecto a los poxvirus, ¿cuál es el sitio celular donde completan su ciclo de replicación, a diferencia de la mayoría de los virus de ADN?

- A) En el citoplasma.
- B) En la membrana plasmática.
- C) En el nucleolo celular.
- D) En las mitocondrias.

20. En la patogenia de la viruela humana, ¿qué evento sigue a la viremia secundaria?

- A) La desaparición inmediata de los síntomas sistémicos.
- B) La erupción de pústulas características en la piel y mucosas.
- C) La inmunización automática contra el parvovirus B19.
- D) La formación de inclusiones citoplasmáticas denominadas cuerpos de Molluscum.

21. ¿Cuál es el reservorio natural de la viruela del mono (Mpox) y cómo se clasifica su transmisión al ser humano?

- A) Es un producto de laboratorio usado para vacunas.
- B) Su reservorio son las aves migratorias y es una infección vectorial.
- C) Se encuentra en animales (monos, ardillas) y es una zoonosis.
- D) Es un virus exclusivo de humanos transmitido por el aire.

22. ¿Cuál es la morfología característica de las lesiones producidas por el virus del Molusco Contagioso?

- A) Exantema maculopapular difuso en 'encaje'.
- B) Vesículas transparentes que siguen el trayecto de un nervio.
- C) Pústulas hemorrágicas que dejan cicatrices profundas.
- D) Nódulos umbilicados con un tapón caseoso central.

23. En el diagnóstico de laboratorio del molusco contagioso, ¿qué hallazgo histopatológico es determinante?

- A) Presencia de grandes inclusiones citoplásmicas eosinofílicas (cuerpos de Molluscum).
- B) Presencia de anticuerpos IgM contra el antígeno eritrocitario P.
- C) Aislamiento de linfocitos CD4 bajos en sangre periférica.
- D) Detección de ADN monocatenario mediante PCR.

24. ¿Cómo se transmiten comúnmente las zoonosis por poxvirus como el Orf y la viruela bovina?

- A) Por contacto directo con lesiones de animales infectados (ovejas, vacas).
- B) Por la picadura de garrapatas infectadas.
- C) A través del consumo de leche no pasteurizada.
- D) Por inhalación de polvo contaminado en establos.

25. Un niño de 18 meses presenta bronquiolitis y síntomas de infección respiratoria grave. Se detecta un parvovirus en sus secreciones. ¿Cuál es el agente más probable?

- A) Virus del Molusco Contagioso.
- B) Virus Orf.
- C) Bocavirus.
- D) Parvovirus B19.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la prevención del parvovirus humano es correcta según el material?

- A) La vacunación sistemática en la infancia es el método principal.
- B) El lavado de manos y el uso de tapabocas ayudan a prevenir la diseminación.
- C) El uso de preservativos garantiza la eliminación del riesgo de contagio de B19.
- D) Las vacunas para perros y gatos protegen también a los humanos.

27. ¿Qué factor puede exacerbar o provocar la recurrencia del exantema en la quinta enfermedad durante varias semanas?

- A) El tratamiento con antibióticos de amplio espectro.
- B) La exposición a la luz solar, calor o ejercicio físico.
- C) El consumo de alimentos ácidos.
- D) La reinfección inmediata por el mismo serotipo del virus.

28. En el contexto de la viruela del mono (Mpox), ¿cuándo se considera que una persona deja de ser infecciosa?

- A) A los 5 días de iniciado el tratamiento con Cidofovir.
- B) Inmediatamente después de recibir la vacuna post-exposición.
- C) Cuando las lesiones se han cubierto de costras, estas han caído y hay piel nueva debajo.
- D) En cuanto desaparece la fiebre inicial.

29. ¿Cuál es la causa del exantema y la artralgia en la segunda fase de la infección por parvovirus B19?

- A) La toxicidad sistémica por la liberación de hemoglobina fetal.
- B) La respuesta inmunitaria y el depósito de complejos antígeno-anticuerpo.
- C) Una sobreinfección bacteriana oportunista en la piel.
- D) La replicación viral directa en los sinoviocitos y queratinocitos.

30. De acuerdo con la clasificación de los poxvirus, ¿cuál de ellos se asocia con el 'Nódulo del Milker'?

- A) Virus Vaccinia.
- B) Virus de la estomatitis papulosa bovina.
- C) Seudoviruela bovina.
- D) Viruela de Tana.

31. En el caso clínico presentado, ¿por qué la madre presentaba cansancio y dolor articular mientras la hija solo tenía el exantema facial?

- A) Porque la madre padecía una enfermedad autoinmune no relacionada.
- B) Porque el B19 produce síntomas diferentes según la edad (artritis en adultos vs exantema en niños).
- C) Porque el virus B19 muta al pasar de niño a adulto.
- D) Porque la madre estaba en la fase infecciosa y la hija en la fase prodrómica.

32. ¿Qué característica genómica comparten los virus de las familias Parvoviridae y Poxviridae según el material?

- A) Ambos son virus con genoma de ADN monocatenario.
- B) Ambos son virus cuyo material genético principal es el ADN.
- C) Ambos requieren una enzima retrotranscriptasa para replicarse.
- D) Ambos poseen genomas de ADN de gran tamaño.

33. ¿Cómo se pueden eliminar físicamente los nódulos del molusco contagioso para acelerar la curación?

- A) Raspado (curetaje), nitrógeno líquido o soluciones de yodo.
- B) Mediante la aplicación de ungüentos antibióticos potentes.
- C) Aspiración con aguja fina del contenido caseoso.
- D) Exposición prolongada a la luz ultravioleta.

34. ¿Cuál es la tasa de mortalidad aproximada asociada a la Viruela Mayor?

- A) Entre el 15% y el 40%.
- B) Exactamente el 50% debido a la respuesta inmunitaria.
- C) Menos del 1%.
- D) Casi del 100% en todos los casos.

35. ¿Qué síntoma inicial e inespecífico caracteriza el 'periodo prodrómico' del parvovirus B19?

- A) Anemia hemolítica súbita en pacientes sanos.
- B) Fiebre, escalofríos, malestar y mialgias.
- C) Descamación severa de las palmas de las manos.
- D) Cefalea intensa y lumbalgia de tipo pustuloso.

36. ¿En qué región anatómica suele aparecer primero el exantema de la viruela antes de extenderse al resto del cuerpo?

- A) En el área genital únicamente.
- B) Exclusivamente en las mejillas.
- C) En las plantas de los pies.
- D) En la cavidad bucal.

37. En pacientes inmunodeprimidos, ¿qué curso suele tomar la infección por parvovirus B19?

- A) Transformación maligna de los precursores eritroides (leucemia).
- B) Infección latente en las neuronas sensitivas.
- C) Resolución acelerada por hiperactividad inmune.
- D) Enfermedad crónica por incapacidad de aclarar la viremia.

38. ¿Qué característica del genoma de los parvovirus hace que su replicación sea dependiente de la fase S del ciclo celular de la célula huésped?

- A) Su gran tamaño requiere mucha energía mitocondrial.
- B) La necesidad de polimerasas de ADN celulares que solo se expresan durante la división.
- C) La presencia de una envoltura que se disuelve con el huso mitótico.
- D) Su capacidad para inducir apoptosis en células en reposo.

6. Picornavirus

Virología · 34 preguntas · Fuente: Unidad 5 Picornavirus.pdf

1. La descripción más correcta de los picornavirus es:

- A) ARN negativo segmentado, cápside helicoidal y envoltura.
- B) ADN bicatenario lineal, fibras y pentonas.
- C) ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.
- D) ADN monocatenario, eritrotropo y envuelto.
- E) ARN bicatenario con transcriptasa inversa.

2. Los enterovirus, aunque se transmiten por vía fecal-oral, normalmente:

- A) Se destruyen siempre en el estómago.
- B) Requieren picadura de mosquito.
- C) Solo infectan el ojo.
- D) Tienen envoltura muy frágil.
- E) No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.

3. Qué propiedad favorece la transmisión fecal-oral de enterovirus?

- A) Labilidad extrema a pH neutro.
- B) Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.
- C) Necesidad de vector biológico.
- D) Latencia en ganglios sensitivos.
- E) Replicación solo nuclear.

4. Los rinovirus se diferencian de los enterovirus porque:

- A) Son virus ADN envueltos.
- B) Se transmiten por heces de felinos.
- C) Producen huevos en vías biliares.
- D) Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 °C.
- E) Tienen fase de trofozoito.

5. El poliovirus puede producir parálisis porque afecta principalmente:

- A) Linfocitos B de amígdala.
- B) Células precursoras eritroides.
- C) Neuronas motoras del asta anterior.
- D) Conductos biliares intrahepáticos.
- E) Queratinocitos del estrato córneo.

6. Coxsackie A se vincula clásicamente con:

- A) Herpangina y mano-pie-boca.
- B) Rabia paralítica.
- C) Sarcoma de Kaposi.
- D) Fasciolosis hepática.
- E) Neurocisticercosis.

7. Coxsackie B debe recordarse por su relación con:

- A) Verrugas plantares.
- B) Hidatidosis pulmonar.
- C) Paludismo terciario.
- D) Leishmaniasis visceral.
- E) Miocarditis y pleurodinia.

8. En picornavirus, la replicación ocurre principalmente en:

- A) Núcleo con inclusión grande.
- B) Citoplasma de la célula.
- C) Mitocondria exclusivamente.
- D) Eritrocito sin núcleo.
- E) Intestino del mosquito.

9. Un cuadro de meningitis aseptica en verano por virus pequeño ARN positivo puede relacionarse con:

- A) Poxvirus.
- B) Toxoplasma.
- C) Fasciola.
- D) Enterovirus.
- E) Bothrops.

10. La prevención de poliomiелitis se basa principalmente en:

- A) Vacunación.
- B) Suero antiofidico.
- C) Antibiotico betalactamico.
- D) Desparasitación canina única.
- E) Cocido de pescado.

11. En términos de estabilidad ambiental, ¿qué diferencia fundamental existe entre los Rinovirus y los Enterovirus?

- A) Los Enterovirus se inactivan rápidamente a temperatura ambiente, a diferencia de los Rinovirus.
- B) Los Rinovirus son lábiles al pH ácido, mientras que los Enterovirus son resistentes a un rango de pH de 3 a 9.
- C) Los Enterovirus requieren temperaturas de 33 °C para replicarse, mientras que los Rinovirus prefieren los 37 °C.
- D) Los Rinovirus son resistentes a los detergentes y solventes orgánicos, pero los Enterovirus no.

12. ¿Por qué el nombre 'Enterovirus' se considera paradójico en relación con la patología que provocan habitualmente?

- A) Porque normalmente no provocan enfermedades entéricas, a pesar de transmitirse por vía fecal-oral.
- B) Porque su replicación principal ocurre en los pulmones antes de migrar al tejido diana.
- C) Porque son los únicos virus que requieren de la bilis para activar su cápside infectante.
- D) Porque solo infectan el sistema nervioso central y nunca entran en contacto con el intestino.

13. Durante la patogenia de una infección por Enterovirus, ¿qué evento precede inmediatamente a la aparición de los síntomas clínicos?

- A) La viremia secundaria que distribuye el virus al tejido diana.
- B) La inhibición total de la replicación por anticuerpos humorales.
- C) La eliminación masiva del virus únicamente a través de las secreciones orales.
- D) La formación de lesiones vesiculares en la mucosa orofaríngea exclusivamente.

14. ¿Qué porcentaje aproximado de las infecciones por Poliovirus resultan en una enfermedad asintomática?

- A) 90%
- B) 10%
- C) 50%
- D) 1%

15. ¿Cuál es el serotipo de Poliovirus responsable del 85% de los casos de poliomiелitis paralítica?

- A) Tipo 1
- B) Tipo 2
- C) Tipo 4
- D) Tipo 3

16. La poliomiелitis paralítica se caracteriza clínicamente por presentar:

- A) Rigidez de nuca persistente que evoluciona a coma profundo en 24 horas.
- B) Debilidad muscular progresiva que siempre comienza en los músculos craneales.
- C) Parálisis espástica simétrica con pérdida total de la sensibilidad térmica.
- D) Parálisis flácida asimétrica sin pérdida sensorial.

17. En el contexto de las infecciones por Coxsackievirus, ¿cuál es la principal diferencia clínica entre los grupos A y B?

- A) Solo el grupo B es capaz de causar meningitis aséptica en adultos.
- B) El grupo A se asocia frecuentemente con lesiones vesiculares, mientras que el grupo B causa miocarditis y pleurodinia.
- C) El grupo B produce únicamente infecciones respiratorias, mientras que el grupo A afecta al hígado.
- D) El grupo A es transmitido por mosquitos, a diferencia del grupo B que es fecal-oral.

18. ¿Qué cuadro clínico se caracteriza por fiebre, faringitis y lesiones vesiculares en el paladar blando y la úvula?

- A) Enfermedad de manos, pies y boca
- B) Meningitis aséptica
- C) Herpangina
- D) Pleurodinia

19. La pleurodinia, también conocida como 'abrazo del diablo', es causada predominantemente por:

- A) Poliovirus tipo 1
- B) Coxsackievirus grupo B
- C) Rinovirus humano
- D) Echovirus 11

20. ¿Cuál es el agente causal más frecuentemente asociado con la meningitis vírica por Echovirus mencionada en el material?

- A) Poliovirus tipo 2
- B) Coxsackie A16
- C) Echovirus 11
- D) Echovirus 7

21. Para el diagnóstico de laboratorio de poliomiелitis, ¿cuál es la muestra clínica donde el virus se detecta con mayor dificultad?

- A) Faringe
- B) Heces
- C) Líquido cefalorraquídeo (LCR)
- D) Sangre

22. En la actualidad, ¿por qué se prefiere el uso de la Vacuna de Poliomiелitis Inactivada (VPI) sobre la Oral (VPO)?

- A) Porque es más económica y fácil de administrar en campañas masivas.
- B) Porque genera una mayor producción de anticuerpos secretores (IgA) en el intestino.
- C) Debido a su mejor perfil de seguridad al eliminar el riesgo de poliomiелitis asociada a la vacuna.
- D) Porque induce una inmunidad de por vida con una sola dosis.

23. ¿Cuál es uno de los inconvenientes significativos de la Vacuna de la Poliomiелitis Oral (VPO) mencionado en el material?

- A) Incapacidad absoluta para generar inmunidad de grupo.
- B) Es el único tipo de vacuna que se inactiva por la luz solar.
- C) Necesidad estricta de jeringuillas y agujas esterilizadas para su uso.
- D) Riesgo de diseminación del virus atenuado a personas próximas no vacunadas.

24. ¿Qué factor ambiental favorece la replicación de los Rinovirus en el cuerpo humano?

- A) La alta acidez del tracto gastrointestinal.
- B) La presencia de enzimas proteolíticas en el páncreas.
- C) La temperatura de 33 °C de las vías respiratorias superiores.
- D) Un ambiente con baja humedad y alta concentración de CO₂.

25. ¿Cuál es la medida de prevención más eficaz recomendada para evitar la propagación de los Rinovirus?

- A) Inhalación de aire seco y frío para reducir la carga viral.
- B) Uso de antibióticos profilácticos durante el invierno.
- C) Lavado de manos frecuente y desinfección de objetos contaminados.
- D) Administración de la vacuna anual polivalente.

26. El periodo de incubación general mencionado para los Enterovirus varía entre:

- A) 24 y 48 horas.
- B) Exactamente 14 días en todos los casos.
- C) 3 y 6 meses.
- D) 1 y 35 días.

27. ¿Qué determina la extensión de la parálisis en un paciente con poliomiелitis paralítica?

- A) La localización y el número de neuronas motoras destruidas por el virus.
- B) La cantidad de virus eliminada a través de las heces.
- C) La presencia de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo.
- D) La velocidad de la viremia primaria inicial.

28. ¿Cuál es el tiempo de recuperación promedio mencionado para los casos de poliomiелitis que no resultan en muerte?

- A) 6 meses a 2 años.
- B) 30 días exactos.
- C) 1 a 2 semanas.
- D) Más de 10 años.

29. En neonatos, las infecciones por Coxsackievirus grupo B son especialmente graves debido a que pueden provocar:

- A) Sordera permanente por destrucción del nervio auditivo.
- B) Fiebre e insuficiencia cardíaca.
- C) Diabetes insulín dependiente de inicio súbito.
- D) Ceguera por conjuntivitis hemorrágica.

30. ¿Cuál es la función principal de la técnica de RT-PCR en el diagnóstico de meningitis por Enterovirus?

- A) Sustituir por completo a la vacunación como medida de salud pública.
- B) Distinguir rápidamente una meningitis por Enterovirus de una meningitis bacteriana.
- C) Determinar la resistencia del virus al cloro en aguas residuales.
- D) Cuantificar la cantidad de bilis presente en el estómago del paciente.

31. ¿Verdadero o Falso? Los Enterovirus son conocidos por causar frecuentemente diarreas profusas en niños pequeños.

- A) Verdadero
- B) Falso

32. ¿Qué género de la familia Picornaviridae incluye al virus de la Hepatitis A?

- A) Hepatovirus
- B) Enterovirus
- C) Aphthovirus
- D) Cardiovirus

33. Sobre la replicación viral de los Picornavirus, se puede afirmar que:

- A) El virus se replica íntegramente en el citoplasma de la célula huésped.
- B) Utilizan el núcleo celular para la síntesis de sus proteínas de cápside.
- C) Requieren integrar su genoma en el ADN celular mediante una retrotranscriptasa.
- D) La replicación ocurre exclusivamente dentro de las mitocondrias para obtener energía.

34. La enfermedad de manos, pies y boca se asocia específicamente con el serotipo:

- A) Coxsackie A16
- B) Poliovirus tipo 1
- C) Coxsackie B5
- D) Echovirus 11

7. Orthomixovirus y Reovirus

Virología · 33 preguntas · Fuente: Unidad 6 Orthomixovirus y Reovirus.pdf

1. La estructura de influenza A y B incluye:

- A) ADN circular sin envoltura.
- B) Un solo ADN monocatenario.
- C) ARN positivo no segmentado.
- D) Capsidem desnuda con espículas ausentes.
- E) Ocho segmentos de ARN y envoltura.

2. El cambio antigenico menor por mutacion en influenza A y B se denomina:

- A) Salto antigenico.
- B) Deriva antigenica.
- C) Latencia ganglionar.
- D) Excistacion.
- E) Autoinfección.

3. El cambio mayor por reorganizacion de segmentos ocurre sobre todo en:

- A) Influenza C.
- B) Rinovirus.
- C) Parvovirus B19.
- D) Influenza A.
- E) VHH-6.

4. Qué glicoproteinas son los antigenos principales de influenza?

- A) Gp120 y gp41.
- B) E1 y E2 del HPV.
- C) Hemaglutinina y neuraminidasa.
- D) Hexona y pentona.
- E) VP1 y VP2 de parvovirus.

5. La neuraminidasa facilita principalmente:

- A) Liberacion de nuevos viriones.
- B) Entrada por retrotranscripcion.
- C) Conversion de quiste a trofozoito.
- D) Penetracion larvaria cutanea.
- E) Produccion de huevos operculados.

6. El genoma segmentado de influenza facilita pandemias porque permite:

- A) Fijacion irreversible de un solo subtipo.
- B) Ausencia de variabilidad genetica.
- C) Transformacion en bacteria.
- D) Multiplicacion sin células.
- E) Reorganizacion entre cepas humanas y animales.

7. Un diagnóstico molecular temprano de influenza se apoya mejor en:

- A) Cinta adhesiva perianal.
- B) RT-PCR de muestra respiratoria.
- C) Gota gruesa hepática.
- D) Biopsia de piel para huevos.
- E) Hemocultivo micologico.

8. Los reovirus/rotavirus se caracterizan por:

- A) ADN monocatenario envuelto.
- B) ARN negativo con forma de bala.
- C) Protozoo flagelado con quiste.
- D) ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.
- E) Cestodo de varios metros.

9. Rotavirus produce diarrea especialmente por:

- A) Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción.
- B) Invasión de vías biliares por adultos.
- C) Necrosis de neuronas del asta anterior.
- D) Quistes tisulares en músculo.
- E) Toxina de veneno crotálico.

10. La prevención específica más importante frente a rotavirus grave en lactantes es:

- A) Antiveneno equino.
- B) Vacuna HPV.
- C) Vacunación oral.
- D) Cocci de pescado.
- E) Uso de preservativo exclusivo.

11. ¿Cuál es la principal diferencia estructural en el genoma segmentado entre los virus de la gripe A y B comparados con el virus de la gripe C?

- A) Los virus A y B poseen 7 segmentos de ARN, mientras que el C posee 8.
- B) El virus de la gripe C no posee genoma segmentado, a diferencia de A y B.
- C) Los virus A y B poseen 8 segmentos de ARN, mientras que el C posee 7.
- D) Los virus A y B poseen genoma bicatenario, mientras que el C es monocatenario.

12. ¿Qué proceso es responsable de la aparición de pandemias de gripe y a qué tipo de virus afecta exclusivamente?

- A) La reorganización genómica en el virus de la gripe B.
- B) El salto antigénico (reorganización) en el virus de la gripe A.
- C) La deriva antigénica (mutación) en los virus de la gripe A y B.
- D) La mutación puntual en la proteína M2 del virus de la gripe A.

13. ¿En qué parte de la célula hospedadora ocurre la transcripción y replicación del genoma del virus de la gripe, a diferencia de la mayoría de los virus ARN?

- A) Núcleo.
- B) Citoplasma.
- C) Aparato de Golgi.
- D) Retículo endoplásmico.

14. ¿Cuál es la función principal de la Hemaglutinina (HA) en el ciclo de infección del virus de la gripe?

- A) Escindir el ácido siálico para permitir la liberación de los viriones.
- B) Formar un canal de protones para la pérdida de la envoltura.
- C) Actuar como la polimerasa principal para la síntesis de ARNm.
- D) Unirse a receptores de ácido siálico y facilitar la fusión de membranas.

15. En el contexto de la patogenia de la gripe, ¿qué moléculas son responsables de los síntomas sistémicos pseudogripales como fiebre, mialgias y cefalea?

- A) La destrucción directa de las células alveolares.
- B) La viremia persistente en sangre periférica.
- C) La presencia de anticuerpos IgG en la mucosa.
- D) Respuestas de interferón y citocinas.

16. ¿Cuál es la recomendación principal respecto a la vacuna de la gripe en pacientes con alergia grave al huevo?

- A) Deben recibir únicamente la vacuna de virus vivos atenuados.
- B) La alergia al huevo no tiene relación con la vacunación antigripal.
- C) No deben recibir la vacuna convencional, aunque existen alternativas sin proteínas de huevo.
- D) Pueden vacunarse sin restricciones si son mayores de 50 años.

17. ¿Cuál es la característica estructural distintiva de la familia Reoviridae, como Rotavirus?

- A) ARN monocatenario segmentado con envoltura derivativa.
- B) ARN monocatenario positivo con envoltura lipídica.
- C) ARN bicatenario segmentado y carencia de envoltura.
- D) ADN bicatenario circular con cápside pleomorfa.

18. ¿Qué cambio estructural debe sufrir el Rotavirus en el tubo digestivo para volverse infeccioso?

- A) Fusión inmediata con la membrana plasmática del estómago.
- B) Adquisición de una envoltura lipídica a partir de los enterocitos.
- C) Proteólisis de la cápside externa para formar una partícula subvívica intermedia.
- D) Pérdida total de la cápside interna antes de la penetración.

19. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal por el cual el Rotavirus causa diarrea líquida?

- A) Invasión de la mucosa colónica con producción de moco y sangre.
- B) Inducción de una respuesta inflamatoria sistémica con leucocitosis fecal.
- C) Atrofia y aplanamiento de las microvellosidades del intestino delgado.
- D) Bloqueo irreversible de los receptores de HA en el epitelio respiratorio.

20. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar una infección por Rotavirus debido a su sensibilidad?

- A) Observación directa de corpúsculos de Negri.
- B) Cultivo en agar sangre a 37 °C.
- C) PCR.
- D) Hemaglutinación indirecta de suero pareado.

21. ¿Qué complicación neurológica se asocia con parálisis y debilidad muscular tras una infección por gripe?

- A) Encefalitis espongiiforme.
- B) Meningitis bacteriana secundaria.
- C) Síndrome de Guillain-Barré.
- D) Síndrome de Reye.

22. ¿Por qué el virus de la gripe B no causa pandemias globales como el virus de la gripe A?

- A) Porque es destruido rápidamente por el pH gástrico.
- B) Porque carece de Hemaglutinina en su superficie.
- C) Porque su genoma no está segmentado.
- D) Porque no experimenta saltos antigénicos por no infectar animales comúnmente.

23. ¿Cuál es el periodo de incubación habitual para el virus de la gripe?

- A) 7 a 14 días.
- B) 2 a 4 semanas.
- C) Menos de 12 horas.
- D) 1 a 4 días.

24. ¿Qué característica del virus de la gripe A permite la clasificación de cepas como H3N2?

- A) El número de segmentos de ARN en el núcleo.
- B) El tipo de polimerasa PB1 que utiliza el virión.
- C) Las variantes de las glucoproteínas Hemaglutinina y Neuraminidasa.
- D) La ciudad donde se aisló el virus por primera vez.

25. En la replicación del virus de la gripe, ¿cómo abandona la nueva partícula vírica la célula hospedadora?

- A) Por lisis celular explosiva.
- B) Mediante exocitosis a través de vacuolas del aparato de Golgi.
- C) Por gemación a través de la membrana plasmática.
- D) A través de puentes intercelulares o nanotubos.

26. ¿Cuál es la función de la proteína M1 en la estructura del virión de la gripe?

- A) Degrada el moco respiratorio para alcanzar el epitelio.
- B) Es la encargada de la transcripción del ARN viral.
- C) Actúa como un canal iónico para acidificar el virión.
- D) Reviste el interior de la envoltura y favorece el ensamblaje.

27. ¿Qué grupo de edad es el más afectado sintomáticamente por las infecciones de Rotavirus?

- A) Recién nacidos en sus primeras 24 horas de vida.
- B) Ancianos mayores de 65 años.
- C) Adolescentes y adultos jóvenes.
- D) Lactantes y niños pequeños.

28. ¿Cómo se transmite principalmente el Rotavirus en guarderías y entornos preescolares?

- A) Gotitas de moco de Pflügge.
- B) Vía fecal-oral.
- C) Picadura de mosquitos Aedes aegypti.
- D) Contacto directo con sangre infectada.

29. En el virus de la gripe, ¿qué evento ocurre cada 2 a 3 años causando brotes locales y se debe a mutaciones puntuales?

- A) Reorganización triple.
- B) Inhibición por interferón.
- C) Salto antigénico.
- D) Deriva antigénica.

30. ¿Cuál es la función de la proteína vírica NSP4 en la infección por Rotavirus?

- A) Inhibe la síntesis de proteínas celulares en el núcleo.
- B) Es la proteína de la cápside que se une al ácido siálico.
- C) Facilita la gemación del virus a través de la membrana.
- D) Actúa como una enterotoxina que induce la secreción de calcio y cloruro.

31. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el virus de la gripe D es correcto según el material proporcionado?

- A) Infecta al ganado vacuno, pero no se sabe si causa enfermedad en humanos.
- B) Posee 11 segmentos de ARN bicatenario.
- C) Es el único Orthomyxovirus que no posee envoltura.
- D) Es el responsable de la mayoría de las epidemias estivales en niños.

32. ¿Qué efecto tiene el virus de la gripe sobre el epitelio respiratorio que facilita infecciones bacterianas secundarias?

- A) Cierre de los bronquiolos por inflamación fibrótica.
- B) Aumento excesivo de la producción de moco protector.
- C) Inducción de una respuesta de anticuerpos IgA excesiva.
- D) Pérdida de la función ciliar y descamación de células epiteliales.

33. En la nomenclatura de una cepa de gripe como A/Bangkok/1/79 (H3N2), ¿qué representa el número '1'?

- A) El número de orden del aislamiento local.
- B) La cantidad de segmentos de ARN defectuosos.
- C) El nivel de virulencia en una escala del 1 al 10.
- D) El mes en que se produjo el brote.

8. Paramixovirus

Virología · 36 preguntas · Fuente: Unidad 7 Paramixovirus.pdf

1. La estructura general de Paramixovirus corresponde a:

- A) ADN lineal desnudo con fibras.
- B) ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.
- C) ARN positivo desnudo pequeño.
- D) ADN monocatenario eritrotropo.
- E) ARN bicatenario de cápside triple.

2. Un ECP típico de paramixovirus es la formación de:

- A) Huevos con mamelones regulares.
- B) Cuerpos de inclusión nuclear exclusivos.
- C) Larvas filariformes en piel.
- D) Células gigantes multinucleadas por fusión.
- E) Quistes hidatídicos.

3. El virus del sarampión se recuerda porque:

- A) Tiene reservorio principal en gatos.
- B) Se transmite por pescado crudo.
- C) Tiene un solo tipo y el humano es su único hospedero.
- D) Requiere caracol Lymnaea.
- E) Es un cestodo intestinal.

4. ¿Qué dato clínico orienta a sarampión clásico?

- A) Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.
- B) Hidrofobia luego de mordedura.
- C) Úlceras genitales recurrentes.
- D) Diarrea grasa sin fiebre.
- E) Dolor en hipocondrio con huevos biliares.

5. Parainfluenza es importante en pediatría por su relación con:

- A) Sarcoma de Kaposi.
- B) Anemia megaloblástica.
- C) Cisticercosis.
- D) Fasciolosis.
- E) Crup o laringotraqueobronquitis.

6. El virus de la parotiditis se asocia de forma clásica con:

- A) Verrugas plantares y condilomas.
- B) Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.
- C) Bronquiolitis por sincitios en lactantes.
- D) Hidatidosis hepática.
- E) Anemia por B12.

7. El virus respiratorio sincitial causa mayor preocupación en:

- A) Adultos con quiste biliar.
- B) Pescadores con anemia B12.
- C) Pacientes con mordedura de serpiente.
- D) Lactantes con bronquiolitis.
- E) Embarazadas con HPV cutáneo.

8. La proteína F de varios paramixovirus se relaciona con:

- A) Fusión de membranas y sincitios.
- B) Retrotranscripción del ARN.
- C) Liberación por neuraminidasa.
- D) Formación de oocistos.
- E) Penetración de cercarias.

9. La vacuna de sarampion se administra dentro de:

- A) Vacuna antirrabica posexposicion.
- B) Vacuna antirotavirus oral.
- C) Triple viral o SRP/MMR.
- D) Vacuna antihepatitis B exclusiva.
- E) Antiveneno polivalente.

10. Metapneumovirus humano se considera dentro del abordaje de:

- A) Teniasis por carne de cerdo.
- B) Protozoarios urogenitales.
- C) Accidentes ofidicos.
- D) Trematodos hepaticos.
- E) Infecciones respiratorias, sobre todo en ninos.

11. ¿Cuál es la característica estructural del genoma de los Paramixovirus?

- A) Virión con ADN bicatenario circular y nucleocápside icosaédrica.
- B) Virión con ARN bicatenario segmentado sin envoltura.
- C) Virión con ARN de cadena positiva, segmentado y desnudo.
- D) Virión grande con ARN(-) monocatenario en una nucleocápside helicoidal y posee envoltura.

12. Durante el proceso de replicación de los Paramixovirus, ¿en qué compartimento celular ocurre la multiplicación viral?

- A) En el núcleo de la célula.
- B) En la cara externa del retículo endoplásmico rugoso exclusivamente.
- C) En el espacio intermembranoso de la mitocondria.
- D) En el citoplasma celular.

13. ¿A qué componente de la superficie celular se unen inicialmente las proteínas de adhesión HN, H o G de los Paramixovirus?

- A) Ácido siálico de los glucolípidos de la superficie celular.
- B) Colesterol de las balsas lipídicas.
- C) Proteínas de transporte de sodio.
- D) Fosfolípidos neutros de la bicapa lipídica.

14. El efecto citopático característico de los Paramixovirus, consistente en células gigantes multinucleadas, se denomina:

- A) Coilocitosis.
- B) Sincitios.
- C) Lisis por apoptosis.
- D) Cuerpos de Negri.

15. En relación al Virus del Sarampión, ¿cuál afirmación sobre su transmisión es correcta?

- A) Se requiere contacto directo con fluidos gastrointestinales.
- B) Solo se transmite durante la fase de exantema activo.
- C) Las gotitas respiratorias pueden quedar suspendidas en el aire hasta 2 horas.
- D) Se transmite principalmente por picaduras de mosquitos infectados.

16. ¿Qué hallazgo clínico es considerado patognomónico para el diagnóstico precoz del sarampión antes del exantema generalizado?

- A) Manchas de Koplik.
- B) Adenopatías cervicales dolorosas crónicas.
- C) Fiebre reumática aguda.
- D) Presencia de vesículas umbilicadas en el tronco.

17. ¿Cuál es la causa fisiopatológica de la aparición del exantema típico maculopapuloso en el sarampión?

- A) Producción excesiva de histamina por mastocitos pulmonares.
- B) La respuesta de los linfocitos T frente a las células endoteliales infectadas.
- C) Depósito de complejos inmunes circulantes en la dermis.
- D) Lisis directa de los melanocitos por el virus.

18. ¿Cuál es la complicación más grave del sarampión que representa aproximadamente el 60% de las muertes asociadas?

- A) Panencefalitis esclerosante subaguda.
- B) Diarrea severa con deshidratación.
- C) Neumonía.
- D) Encefalitis aguda postinfecciosa.

19. En el diagnóstico citológico del sarampión, ¿qué característica celular se observa típicamente en muestras teñidas con Giemsa?

- A) Linfocitos atípicos de Downey.
- B) Células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplásmicos.
- C) Células con núcleos en anillo de sello.
- D) Células en 'ojo de búho'.

20. La vacuna SPR para prevenir el sarampión protege contra:

- A) Sarampión, Pertussis y Rubéola.
- B) Sarampión, Parainfluenza y Rinovirus.
- C) Sífilis, Polio y Rubéola.
- D) Sarampión, Paperas y Rubéola.

21. ¿Cuál es la principal diferencia patogénica entre el Virus de la Parainfluenza y el Virus del Sarampión?

- A) Parainfluenza causa una infección sistémica grave con viremia.
- B) Sarampión solo afecta las vías respiratorias superiores.
- C) Parainfluenza no causa viremia ni produce enfermedades sistémicas.
- D) Parainfluenza tiene un solo serotipo, mientras que el sarampión tiene cuatro.

22. Los tipos 1 y 2 del Virus de la Parainfluenza son causas principales de qué síndrome clínico en niños?

- A) Meningitis linfocítica.
- B) Laringotraqueobronquitis (Crup).
- C) Faringoamigdalitis purulenta.
- D) Bronquiolitis obliterante crónica.

23. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para las infecciones por Virus de la Parainfluenza?

- A) Tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico.
- B) Vacunación de emergencia tras la exposición.
- C) Inhalación de vapores fríos o calientes.
- D) Administración inmediata de ribavirina intravenosa.

24. Además de las glándulas parótidas, ¿qué otros órganos se ven frecuentemente afectados por el Virus de la Parotiditis?

- A) Testículos, ovarios, páncreas y sistema nervioso central.
- B) Ventrículos cardíacos y válvulas.
- C) Solo las glándulas lagrimales.
- D) Hígado y bazo exclusivamente.

25. ¿Cuál es una consecuencia potencial de la orquitis causada por el virus de la parotiditis en varones post-púberes?

- A) Cáncer de próstata a corto plazo.
- B) Esterilidad o infertilidad por atrofia testicular.
- C) Aumento excesivo de la producción de testosterona.
- D) Desarrollo de hernias inguinales.

26. ¿Por qué se asocia el virus de la parotiditis con la aparición de diabetes juvenil en algunos pacientes?

- A) Porque el virus consume todas las reservas de glucosa del cuerpo.
- B) Como efecto secundario de la vacuna SPR.
- C) Por una reacción cruzada con la glándula tiroides únicamente.
- D) Debido a la infección y daño directo de las células del páncreas.

27. ¿Cuál es la duración de la inmunidad tras una infección natural por el Virus de la Parotiditis?

- A) Breve, requiriendo reinfecciones cada año.
- B) Dura toda la vida.
- C) Solo protege contra la orquitis, no contra la parotiditis.
- D) Aproximadamente 5 años solamente.

28. ¿Cuál es la causa más habitual de infección aguda y mortal de las vías respiratorias en lactantes y niños pequeños?

- A) Metapneumovirus humano.
- B) Bordetella pertussis.
- C) Virus Respiratorio Sincitial (VRS).
- D) Virus de la Influenza A.

29. ¿Qué mecanismo fisiopatológico explica la dificultad respiratoria severa en lactantes con infección por VRS?

- A) Parálisis de los músculos intercostales.
- B) Espasmo laríngeo reflejo permanente.
- C) Destrucción total de los capilares alveolares.
- D) Obstrucción por tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico.

30. En cuanto a la epidemiología del Virus Respiratorio Sincitial, ¿cuándo suelen producirse los brotes epidémicos?

- A) Principalmente durante el verano.
- B) Cada 10 años, coincidiendo con sequías.
- C) Casi siempre en invierno, todos los años.
- D) Únicamente en climas tropicales húmedos sin variación estacional.

31. ¿Qué técnica de diagnóstico se está convirtiendo en el método de elección para identificar rápidamente virus como Parainfluenza y Metapneumovirus?

- A) Observación directa por microscopía electrónica.
- B) Prueba de la tuberculina.
- C) RT-PCR.
- D) Hemocultivos en medios enriquecidos.

32. Respecto al Metapneumovirus humano, ¿en qué grupos puede provocar afecciones respiratorias más graves?

- A) No causa enfermedad grave en ningún grupo.
- B) Exclusivamente en pacientes con enfermedades renales crónicas.
- C) Niños pequeños, adultos mayores e inmunocomprometidos.
- D) Solo en adultos jóvenes sanos.

33. ¿Cuál es la función principal de la proteína de matriz M en el virión de los Paramixovirus?

- A) Actuar como receptor para el ácido siálico.
- B) Transcribir el ARN genómico en ARNm.
- C) Inducir la formación de anticuerpos neutralizantes.
- D) Facilitar el ensamblaje y revestir la cara interna de la envoltura.

34. ¿Qué característica epidemiológica comparten el virus del sarampión y los virus parainfluenza humanos según la fuente?

- A) El ser humano es su principal hospedador.
- B) Ambos requieren ambientes desérticos para su propagación.
- C) Ambos se transmiten por vectores artrópodos.
- D) Poseen más de 20 serotipos diferentes cada uno.

35. En una infección por sarampión, ¿en qué momento se inicia el período de contagio en relación a los síntomas?

- A) Exactamente 14 días después de que desaparece la fiebre.
- B) Solo cuando las costras se caen.
- C) Antes y después de la aparición de los síntomas.
- D) Solo durante la presencia de las manchas de Koplik.

36. Si un paciente presenta fiebre, tos, rinorrea y conjuntivitis seguida de un exantema que inicia en la cabeza y baja al tronco, ¿qué diagnóstico se debería sospechar prioritariamente?

- A) Infección bacteriana por estreptococo.
- B) Parotiditis aguda bilateral.
- C) Sarampión.
- D) Gripe estacional común.

9. Rhabdovirus

Virología · 30 preguntas · Fuente: Unidad 8 Rhabdovirus.pdf

1. La morfología clásica del virus de la rabia es:

- A) Capsidem icosaedrica desnuda pequena.
- B) Bacilo grampositivo esporulado.
- C) Huevo operculado grande.
- D) Virion envuelto en forma de bala.
- E) Gusano plano segmentado.

2. El genoma del virus rabico es:

- A) ADN circular bicatenario.
- B) ARN positivo segmentado.
- C) ARN monocatenario negativo.
- D) ADN monocatenario lineal.
- E) ARN bicatenario con cápside triple.

3. Una exposicion humana tipica a rabia ocurre por:

- A) Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.
- B) Ingestion de pescado crudo.
- C) Picadura de Anopheles hembra.
- D) Contacto con heces de gato con ooquistes.
- E) Consumo de berro con metacercarias.

4. Qué factor acorta o agrava el periodo de incubacion de rabia?

- A) Lesion lejana en pie sin inoculo.
- B) Vacunacion prevía completa.
- C) Baja concentracion viral.
- D) Piel intacta sin contacto.
- E) Herida cercana al cerebro.

5. Despues de replicarse en el sitio de inoculacion, el virus rabico progresa hacia el SNC por:

- A) Huevos en vía biliar.
- B) Transporte neural retrogrado.
- C) Fecalismo intestinal.
- D) Viremia masiva por eritrocitos.
- E) Larvas por circulacion portal.

6. El tiempo de observacion del perro o gato agresor se relaciona con el periodo de transmisibilidad y suele ser:

- A) 24 horas.
- B) 3 meses.
- C) 2 anos.
- D) 10 dias.
- E) 18 dias.

7. El cuadro neurologico clasico de rabia puede incluir:

- A) Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.
- B) Diarrea grasa crónica.
- C) Exantema en mejilla abofeteada.
- D) Condilomás genitales.
- E) Anemia megaloblastica por pescado.

8. La conducta inicial más correcta ante mordedura sospechosa es:

- A) Cerrar la herida sin limpieza.
- B) Aplicar torniquete por 24 horas.
- C) Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.
- D) Esperar fiebre antes de actuar.
- E) Dar solo analgésico y alta.

9. El diagnóstico postmortem clásico de rabia puede apoyarse en:

- A) Huevos mamelonados en heces.
- B) Quistes de Giardia en duodeno.
- C) Proglotides gravidas.
- D) Amastigotes en sangre periférica.
- E) Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.

10. Filovirus, incluidos Ebola y Marburg, se diferencian por ser:

- A) ADN pequeños desnudos eritrotropos.
- B) ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.
- C) Protozoos con flebotomo vector.
- D) Cestodos por carne bovina.
- E) Trematodos con caracol Lymnaea.

11. ¿Cuál es la característica estructural que define la forma del virión de la familia Rhabdoviridae?

- A) Cápside filamentosa de gran longitud sin envoltura.
- B) Morfología en forma de bala con envoltura lipídica.
- C) Forma pleomórfica con genoma de ADN bicatenario.
- D) Estructura icosaédrica desnuda con espículas de glucoproteína.

12. ¿En qué compartimento celular tiene lugar la replicación del virus de la rabia?

- A) Citoplasma de la célula hospedadora.
- B) Asociado exclusivamente a la membrana citoplasmática.
- C) Dentro de las mitocondrias para aprovechar el ATP.
- D) Núcleo celular para la transcripción genómica.

13. Durante la fase de incubación, ¿dónde se replica principalmente el virus antes de invadir el sistema nervioso central?

- A) En los ganglios linfáticos regionales.
- B) En el tejido muscular del sitio de inoculación.
- C) Directamente en la sangre.
- D) En las glándulas salivales del humano infectado.

14. ¿Cuál es la duración típica del periodo de incubación en humanos según el material proporcionado?

- A) De 2 a 10 días máximo.
- B) De 1 a 5 años invariablemente.
- C) Exactamente 10 días en todos los casos.
- D) De 60 a 365 días.

15. ¿Qué factor determina que el periodo de incubación sea más corto en una persona infectada?

- A) La proximidad de la herida al cerebro.
- B) La administración inmediata de antibióticos.
- C) El tipo de grupo sanguíneo del huésped.
- D) El sexo de la persona afectada.

16. Respecto a la inmunidad frente a la infección natural por rabia, ¿cuál es la situación de la respuesta celular?

- A) Es nula durante el transcurso de la infección.
- B) Es la principal defensa que elimina al virus del músculo.
- C) Solo se activa en la fase de coma.
- D) Se activa rápidamente tras la mordedura del animal.

17. ¿Por qué la inmunidad humoral no suele salvar al paciente una vez aparecen los síntomas?

- A) Porque los anticuerpos no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está establecido.
- B) Porque los anticuerpos no pueden entrar al SNC.
- C) Porque el virus destruye los linfocitos B del suero.
- D) Porque el virus cambia sus antígenos de superficie constantemente.

18. ¿Cuál es el reservorio principal de la rabia salvaje mencionado como de mayor importancia actual en humanos?

- A) Perros callejeros sin vacunar.
- B) Ratones y otros pequeños roedores domésticos.
- C) Murciélago hematófago (*Desmodus rotundus*).
- D) Aves de rapiña infectadas.

19. ¿A qué se debe el síntoma característico de la hidrofobia en los pacientes con rabia?

- A) A que el agua destruye la envoltura del virus en la garganta.
- B) A una mutación del virus que lo hace hidrofóbico.
- C) A la pérdida total del sentido de la sed.
- D) Al dolor intenso que sienten al intentar tragar agua.

20. ¿Qué son los Corpúsculos de Negri y en qué porcentaje de pacientes aparecen?

- A) Células gigantes multinucleadas; aparecen en el 100% de los infectados.
- B) Agregados de nucleocápsides víricas; aparecen en el 70%-90% de los casos.
- C) Cristales de sales de calcio; aparecen en el 15% de los pacientes.
- D) Vacuolas de grasa en el citoplasma; aparecen solo en perros.

21. ¿Cuál es el método de elección para la detección del genoma del virus de la rabia por su rapidez y sensibilidad?

- A) Cultivo en huevos embrionados.
- B) Tinción de Gram en líquido cefalorraquídeo.
- C) RT-PCR.
- D) Prueba de aglutinación en látex.

22. ¿Cuál es la primera medida recomendada inmediatamente después de la mordedura de un animal sospechoso?

- A) Suturar la herida lo más rápido posible.
- B) Aplicar un torniquete por encima de la lesión.
- C) Administrar analgésicos potentes y esperar síntomas.
- D) Lavar profundamente la herida con agua y jabón.

23. ¿En qué consiste la profilaxis post-exposición completa para una persona no vacunada previamente?

- A) Dosis única de suero fisiológico y antibióticos.
- B) Vacuna de virus muertos combinada con inmunoglobulina antirrábica humana.
- C) Aislamiento en cuarto oscuro durante 40 días sin medicación.
- D) Inyección de virus vivos atenuados directamente en la herida.

24. ¿Cuál es el tiempo recomendado para observar a un perro o gato que ha mordido a una persona antes de descartar riesgo de transmisión?

- A) 10 días.
- B) 6 meses.
- C) 24 horas.
- D) 45 días.

25. En la fase neurológica, ¿qué otros síntomas fobígenos se presentan además de la hidrofobia?

- A) Fobia al contacto con metales.
- B) Miedo intenso a la oscuridad.
- C) Fobias al viento y a movimientos bruscos.
- D) Rechazo absoluto a los alimentos sólidos únicamente.

26. ¿Cuál de las siguientes es una vía de transmisión menos frecuente pero posible para la rabia humana?

- A) Contacto estrecho piel con piel sin heridas.
- B) Picadura de mosquitos que previamente picaron a un animal rabioso.
- C) Trasplante de tejidos infectados, como la córnea.
- D) Consumo de carne de perro cocida.

27. En la estructura del Rhabdovirus, ¿dónde se localizan las espículas de glucoproteína?

- A) Insertadas en la envoltura lipídica externa.
- B) En el interior del núcleo helicoidal.
- C) Libres en el citoplasma de la célula sin formar parte del virión.
- D) Constituyendo la matriz proteica.

28. ¿Qué tipo de parálisis se menciona como causa final de muerte en la progresión de la rabia?

- A) Parálisis intestinal con necrosis gástrica.
- B) Parálisis que origina insuficiencia respiratoria.
- C) Parálisis de los músculos de la visión.
- D) Parálisis de los miembros inferiores únicamente.

29. Ante una mordedura, ¿en qué caso se podría evitar iniciar la profilaxis post-exposición de inmediato?

- A) Si se analiza al animal y se demuestra que no presenta la infección.
- B) Si la mordedura fue en el pie y no sangró mucho.
- C) Si el paciente tiene un sistema inmune muy fuerte.
- D) Si el perro es de raza pequeña o cachorro.

30. ¿Cuál es la recomendación de la OMS respecto al uso de suero antirrábico local?

- A) Beber el suero mezclado con jugos cítricos.
- B) Gotear o infiltrar suero antirrábico alrededor de la herida.
- C) Inyectarlo por vía intravenosa en el brazo opuesto.
- D) No utilizarlo nunca para evitar alergias cutáneas.

10. Togavirus y Flavivirus

Virología · 30 preguntas · Fuente: Unidad 9 + Togavirus y Alfavirus.pdf

1. Alfavirus y flavivirus comparten como rasgo estructural:

- A) ADN bicatenario sin envoltura.
- B) ARN negativo en forma de bala.
- C) ARN monocatenario positivo con envoltura.
- D) ADN monocatenario eritrotropo.
- E) Genoma circular con transcriptasa inversa.

2. La replicación de alfavirus ocurre principalmente en:

- A) Citoplasma.
- B) Nucleo.
- C) Eritrocito maduro.
- D) Conducto biliar.
- E) Ganglio sensorial.

3. En arbovirus, el término vector biológico se aplica con mayor frecuencia a:

- A) Caracol Lymnaea.
- B) Perro doméstico.
- C) Pescado de agua dulce.
- D) Gato definitivo.
- E) Mosquito hembra hematofago.

4. Dengue grave tras una segunda infección por serotipo distinto se explica mejor por:

- A) Latencia en ganglios dorsales.
- B) Potenciación dependiente de anticuerpos.
- C) Autoinfección intestinal.
- D) Toxina neurotrófica salival.
- E) Destrucción de vitamina B12.

5. En dengue temprano, una combinación diagnóstica útil es:

- A) Cinta adhesiva y coproparasitológico.
- B) Gota gruesa para larvas.
- C) Cultivo de bilis para huevos.
- D) NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.
- E) Biopsia de músculo para quistes.

6. Chikungunya se reconoce clínicamente por:

- A) Fiebre con artralgias intensas y persistentes.
- B) Hidrofobia y espasmos faríngeos.
- C) Diarrea grasa por malabsorción.
- D) Parálisis flácida por asta anterior.
- E) Hematuria por huevos vesicales.

7. Zika tiene especial importancia en gestación por su relación con:

- A) Eritema infeccioso por B19.
- B) Sarcoma de Kaposi neonatal.
- C) Síndrome congénito y microcefalia.
- D) Hidatidosis pulmonar fetal.
- E) Aplasia medular por HPV.

8. La fiebre amarilla se previene de forma específica con:

- A) Vacuna antirrábica únicamente.
- B) Antibiótico macrolido.
- C) Antihelmíntico para perros.
- D) Cocido de pescado.
- E) Vacuna viva atenuada y control vectorial.

9. El virus de la rubéola pertenece al genero:

- A) Flavivirus.
- B) Rubivirus.
- C) Lentivirus.
- D) Enterovirus.
- E) Rhabdovirus.

10. La rubéola congénita se previene principalmente mediante:

- A) Tratamiento con antiveneno.
- B) Hervir pescado de río.
- C) Desección de quistes.
- D) Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.
- E) Observación de animales 10 días.

11. En el contexto de la epidemiología de los arbovirus, ¿qué papel desempeña el ser humano en la mayoría de los ciclos de transmisión?

- A) Vector invertebrado
- B) Hospedador terminal
- C) Reservorio primario
- D) Hospedador natural asintomático

12. ¿Cuál es la complicación clínica más característica que diferencia a la fiebre amarilla de otros flavivirus?

- A) Microcefalia congénita
- B) Ictericia con coloración amarilla de piel y ojos
- C) Artralgia severa
- D) Exantema maculopapular

13. Sobre el tratamiento de las infecciones por alfavirus y flavivirus, ¿cuál es la recomendación estándar?

- A) Antibioticoterapia de amplio espectro
- B) Tratamiento de soporte con líquidos y paracetamol
- C) Uso de aspirina para controlar la fiebre alta
- D) Administración de aciclovir intravenoso

14. ¿Qué hallazgo en el diagnóstico de laboratorio confirma una infección activa por un arbovirus?

- A) Leucocitosis con neutrofilia
- B) Presencia de IgG persistente
- C) Visualización del virus por microscopía óptica
- D) Determinación de anticuerpos IgM

15. El virus de la rubéola se diferencia de otros togavirus principalmente por:

- A) Tener un genoma de ADN bicatenario
- B) No poseer envoltura lipídica
- C) Presentar múltiples serotipos
- D) Su modo de transmisión respiratoria

16. ¿Qué condición favorece la infección por flavivirus a través de receptores Fc?

- A) Deficiencia de vitamina D
- B) Presencia de anticuerpos no neutralizantes
- C) Vacunación previa contra fiebre amarilla
- D) Uso previo de antibióticos

17. ¿Cuál es el vector principal asociado a la transmisión urbana del virus chikungunya y del dengue?

- A) Anopheles gambiae
- B) Aedes aegypti
- C) Culex quinquefasciatus
- D) Aedes albopictus

18. ¿Cuál de estos síntomas es un signo de alarma en la fiebre amarilla que indica progresión a etapa grave?

- A) Cefalea frontal
- B) Dolor de espalda leve
- C) Erupciones cutáneas pruriginosas
- D) Disfunción renal y hemorragias

19. En el diagnóstico diferencial de chikungunya, ¿qué característica clínica es más frecuente en dengue según la tabla comparativa?

- A) Linfopenia severa
- B) Fiebre muy alta
- C) Trombocitopenia
- D) Artralgias intensas

20. ¿Cuál es el periodo de incubación típico de la fiebre amarilla?

- A) 12 a 24 horas
- B) 21 días
- C) 1 a 2 semanas
- D) 3 a 6 días

21. Respecto a la transmisión vertical del chikungunya, ¿cuándo es más probable que la madre infecte al recién nacido?

- A) Durante el primer trimestre únicamente
- B) A través de la lactancia materna exclusiva
- C) Solo si el parto se realiza por cesárea
- D) Si presenta fiebre justo al momento del parto o días antes

22. La naturaleza de la enfermedad provocada por arbovirus está determinada por tres factores principales. ¿Cuál NO es uno de ellos?

- A) Tropismo celular específico de cada virus
- B) Respuesta individual a la infección
- C) Grupo sanguíneo del hospedador
- D) Concentración del virus infectante

23. ¿Cuál es la característica principal de la cápside de los alfavirus y flavivirus?

- A) Pleomórfica
- B) Helicoidal
- C) Icosaédrica
- D) Biconvexa

24. En el vector invertebrado, la infección por arbovirus se caracteriza por ser:

- A) Latente en el sistema nervioso
- B) Transitoria de pocas horas
- C) Lítica
- D) Persistente

25. ¿Qué técnica diagnóstica es preferible para detectar la presencia del virus en sangre durante la fase de fiebre alta?

- A) Prueba de la tuberculina
- B) Aglutinación con látex para IgG
- C) Cultivo en agar sangre
- D) RT-PCR

26. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es causada por un alfavirus y se caracteriza por una fase crónica con dolores articulares persistentes?

- A) Zika
- B) Fiebre del Nilo Occidental
- C) Chikungunya
- D) Rubéola

27. Durante la viremia secundaria de muchos arbovirus, ¿a qué órganos puede diseminarse o amplificarse el virus antes de alcanzar tejidos diana?

- A) Pulmones y tráquea
- B) Intestino delgado y colon
- C) Médula ósea únicamente
- D) Hígado, bazo y ganglios linfáticos

28. ¿Cuál es la principal medida de prevención para evitar la diseminación de cualquier arbovirus en ausencia de vacunas?

- A) Hervir el agua de consumo
- B) Eliminación de vectores y sus zonas de reproducción
- C) Tratamiento preventivo con paracetamol
- D) Uso de mascarillas N95 en lugares públicos

29. Según el material, ¿qué síntoma dermatológico es común en la rubéola?

- A) Exantema, uno de los cinco clásicos de la infancia
- B) Escamas blanquecinas en cuero cabelludo
- C) Vesículas con costras tipo varicela
- D) Nódulos subcutáneos dolorosos

30. ¿Cuál es el hospedador natural y reservorio frecuente para virus como dengue y fiebre amarilla en ciclos selváticos?

- A) Roedores pequeños
- B) Aves migratorias
- C) Cerdos
- D) Monos

11. Retrovirus

Virología · 31 preguntas · Fuente: Unidad 10 + Togavirus y Alfavirus.pdf

1. La característica que define a los retrovirus es la presencia de:

- A) Transcriptasa inversa.
- B) Neuraminidasa.
- C) Hemaglutinina.
- D) Cuerpo de Negri.
- E) Disco succionario.

2. El genoma de VIH se describe mejor como:

- A) ADN bicatenario lineal sin envoltura.
- B) ARN negativo segmentado.
- C) ADN monocatenario sin envoltura.
- D) ARN bicatenario de cápside triple.
- E) ARN monocatenario positivo con envoltura.

3. La integrasa del VIH permite:

- A) Unir virus a ácido sialico.
- B) Incorporar el ADN proviral al genoma celular.
- C) Liberar viriones por neuraminidasa.
- D) Formar quistes resistentes.
- E) Producir huevos embrionados.

4. Las células diana principales del VIH expresan:

- A) Antígeno P eritrocitario.
- B) Receptor de bilis.
- C) Quitina externa.
- D) CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.
- E) Botrios del escolex.

5. La disminucion progresiva de CD4 explica principalmente:

- A) Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.
- B) Anemia por consumo de B12.
- C) Obstruccion intestinal por adultos.
- D) Fiebre por esquizogonia eritrocitaria.
- E) Dermatitis por pediculosis.

6. Una prueba inicial moderna de tamizaje de VIH suele detectar:

- A) Huevos en heces seriadas.
- B) Trofozoitos moviles en fresco.
- C) Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.
- D) Cercarias en agua.
- E) Veneno en sangre.

7. La carga viral por PCR se usa principalmente para:

- A) Identificar huevos operculados.
- B) Clasificar mordeduras ofidicas.
- C) Medir vitamina B12 por cestodos.
- D) Detectar larvas en cinta adhesiva.
- E) Monitorear replicacion y respuesta al tratamiento.

8. La terapia antirretroviral combinada busca:

- A) Eliminar solo bacterias anaerobias.
- B) Bloquear distintas etapas de la replicacion viral.
- C) Neutralizar venenos de serpientes.
- D) Paralizar nematodos intestinales unicamente.
- E) Destruir ooquistes ambientales.

9. HTLV-1 se asocia especialmente con:

- A) Condiloma acuminado.
- B) Rabia paralítica.
- C) Fasciolosis biliar.
- D) Leucemia/linfoma de células T del adulto.
- E) Cisticercosis muscular.

10. Una medida preventiva esencial para VIH es:

- A) Evitar exclusivamente gatos.
- B) Cocinar vegetales acuáticos.
- C) Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.
- D) Observar perros por 10 días.
- E) No caminar descalzo.

11. ¿Cuál es la característica morfológica distintiva de los retrovirus clasificados como Oncovirinae tipo B?

- A) Nucleocápside excéntrica dentro del virión maduro
- B) Nucleocápside de forma cilíndrica
- C) Ausencia de envoltura lipídica externa
- D) Nucleocápside central y esférica

12. En la estructura del VIH, ¿qué función específica cumple la enzima integrasa?

- A) Insertar el ADN proviral en el genoma de la célula hospedadora
- B) Escindir poliproteínas precursoras
- C) Facilitar el anclaje inicial de gp120 al CD4
- D) Convertir el ARN monocatenario en ADN de doble cadena

13. Se estima que parte de la población es resistente a la infección por VIH. ¿A qué se debe este fenómeno según el material?

- A) Producción excesiva de linfocitos T CD8 citotóxicos
- B) Presencia de anticuerpos naturales hiper-eficientes
- C) Ausencia de correceptores como CCR5 o CXCR4 en sus linfocitos
- D) Mutación que impide la expresión de receptores CD4

14. Durante la replicación del VIH, ¿qué ocurre inmediatamente después de que el ADN viral se inserta en el núcleo celular?

- A) Se sintetiza ARN viral a partir del ADN mediante ARN polimerasa celular
- B) La retrotranscriptasa inicia la copia del ARN en ADN
- C) La proteasa comienza a digerir polipéptidos largos
- D) El virión se libera por gemación

15. ¿Cuál es la principal diferencia clínica entre un paciente VIH positivo y uno con SIDA?

- A) La capacidad de transmitir el virus
- B) El recuento de linfocitos T CD4 y la presencia de infecciones oportunistas
- C) La presencia de anticuerpos detectables por ELISA
- D) La necesidad de iniciar tratamiento antirretroviral

16. De acuerdo con las categorías de los CDC, ¿qué parámetros definen la etapa 2 de la infección por VIH?

- A) CD4 superior a 500 y porcentaje al menos 29%
- B) CD4 entre 200 y 499 y porcentaje entre 14% y 28%
- C) CD4 inferior a 200 o afección oportunista
- D) Síndrome tipo mononucleosis sin anticuerpos

17. En un accidente laboral con material contaminado, ¿cuál es el tiempo ideal para iniciar la profilaxis post-exposición?

- A) Solo después de confirmar el resultado de la fuente
- B) Dentro de las primeras 2 horas del suceso
- C) En un plazo máximo de 7 días
- D) Después del síndrome retroviral agudo

18. ¿Qué tumor maligno causado por VHH-8 es característico en pacientes con SIDA?

- A) Linfoma de Burkitt
- B) Linfoma de Hodgkin
- C) Carcinoma hepatocelular
- D) Sarcoma de Kaposi

19. ¿Por qué ELISA se considera una prueba de tamizaje y no confirmatoria definitiva para VIH?

- A) Porque requiere fase de SIDA para ser positivo
- B) Porque es una prueba genómica de ADN
- C) Porque posee alta sensibilidad pero especificidad limitada, pudiendo dar falsos positivos
- D) Porque solo detecta carga viral directa

20. ¿Cuál es la justificación principal del uso de terapia antirretroviral combinada en lugar de un solo fármaco?

- A) Reducir el periodo ventana a pocos días
- B) Disminuir el riesgo de resistencias y mutaciones virales
- C) Eliminar todos los efectos secundarios
- D) Eliminar completamente el virus de reservorios celulares

21. En la cronología del VIH, ¿qué caracteriza a la fase crónica o periodo de latencia clínica?

- A) Mayor viremia y aumento explosivo de carga viral
- B) Replicación viral persistente pero lenta, con descenso gradual de CD4
- C) Recuperación de CD4 por encima del nivel previo
- D) Detención completa de la replicación por anticuerpos

22. ¿Qué ocurre con el riesgo de transmisión sexual y vertical cuando un paciente logra carga viral indetectable?

- A) Aumenta por falsa seguridad y mutaciones
- B) Disminuye drásticamente hasta ser casi inexistente
- C) Solo se elimina el riesgo vertical, no el sexual
- D) Se mantiene igual porque el virus sigue en el ADN celular

23. La glucoproteína gp120 tiene afinidad por CD4. ¿En qué células se encuentra principalmente este receptor?

- A) Linfocitos T, macrófagos y células dendríticas
- B) Linfocitos B y células NK
- C) Neuronas motoras y células musculares
- D) Eritrocitos y plaquetas

24. ¿Cuál es la función del proceso de gemación en el ciclo vital del VIH?

- A) Acelerar la lisis celular por ruptura violenta
- B) Inyectar el ARN viral directamente en el citoplasma
- C) Permitir que el virión salga adquiriendo envoltura lipídica
- D) Fusionar dos células infectadas para formar sincitio

25. ¿Qué efecto tiene la pérdida de linfocitos T CD4 sobre la respuesta de hipersensibilidad retardada?

- A) Aumenta la sensibilidad ante alérgenos comunes
- B) No tiene efecto porque depende solo de anticuerpos
- C) Provoca pérdida o disminución severa de la respuesta
- D) La sustituye por inflamación aguda inespecífica

26. ¿Cuál es la función de la enzima proteasa en el ciclo de vida del VIH?

- A) Digerir polipéptidos largos para formar proteínas y enzimas funcionales
- B) Romper la membrana celular para facilitar entrada
- C) Degradar el ADN de la célula hospedadora
- D) Sintetizar ADN complementario a partir del ARN genómico

27. Dentro de la patogenia, ¿qué significa que el VIH cause una infección lítica?

- A) Que el virus se vuelve menos agresivo con el tiempo
- B) Que la replicación masiva termina destruyendo la célula infectada
- C) Que permanece dormido en el ADN sin producir partículas
- D) Que solo se transmite por líquidos infectados

28. ¿Cuál es una complicación gastrointestinal común en pacientes con SIDA avanzado?

- A) Obstrucción biliar por cálculos de colesterol
- B) Úlceras gástricas por estrés crónico
- C) Diarrea asociada a Salmonella, Shigella y Campylobacter
- D) Aumento de motilidad por sistema simpático

29. ¿Qué papel desempeñan los linfocitos T CD8 en la progresión del VIH?

- A) Son las principales células infectadas y destruidas
- B) Controlan la progresión, pero requieren activación por CD4
- C) Producen anticuerpos detectados en Western Blot
- D) Aceleran la integración del ADN viral en neuronas

30. En la epidemiología del VIH, ¿qué significa el término PVV?

- A) Persona que vive con VIH
- B) Paciente con vacunación vigilada
- C) Población vulnerable al virus
- D) Portador de variantes virulentas

31. ¿Cuál es la causa principal de la demencia relacionada con el SIDA según la patogenia descrita?

- A) Infección de microglía y neuronas por VIH o infecciones oportunistas
- B) Efecto tóxico directo de antirretrovirales a largo plazo
- C) Desnutrición extrema por diarrea crónica
- D) Ruptura masiva de capilares cerebrales por sarcoma de Kaposi

12. Generalidades, huéspedes y prevención

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 1 Parasitología Generalidades.pptx.pdf

1. En parasitología, el huésped definitivo se define mejor como aquel en el que el parásito:

- A) Permanece siempre como quiste ambiental.
- B) Solo se transporta mecánicamente sin cambiar.
- C) Muere antes de completar el ciclo.
- D) No produce ningún dano.
- E) Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.

2. El huésped intermediario se reconoce porque en él ocurre:

- A) Únicamente diagnóstico serológico.
- B) Desarrollo larvario o reproducción asexual.
- C) La eliminación obligatoria de anticuerpos.
- D) El tratamiento farmacológico.
- E) La vacunación del humano.

3. Un reservorio epidemiológico es importante porque:

- A) Siempre elimina el parásito por tos.
- B) Impide toda zoonosis.
- C) Es sinónimo de vector mecánico.
- D) Mantiene el parásito disponible para transmisión.
- E) Solo existe en virus envueltos.

4. La diferencia más adecuada entre vector biológico y mecánico es:

- A) En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.
- B) El biológico nunca transmite enfermedad.
- C) El mecánico siempre inyecta saliva infectante.
- D) Ambos requieren reproducción sexual del parásito.
- E) Solo el mecánico tiene importancia médica.

5. La prevención comunitaria de parasitosis intestinales se centra sobre todo en:

- A) Aislamiento respiratorio estricto permanente.
- B) Antivirales de amplio espectro.
- C) Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.
- D) Vacuna antitetánica como única medida.
- E) Cierre de escuelas sin educación sanitaria.

6. Una parasitosis zoonótica implica que:

- A) Solo existe en cultivos celulares.
- B) No requiere ningún huésped.
- C) Siempre se transmite por transfusión.
- D) Nunca involucra reservorios.
- E) Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.

7. Para parásitos intestinales con eliminación intermitente de formas diagnósticas, ¿qué estrategia mejora el rendimiento?

- A) Radiografía simple única.
- B) Examen coproparasitológico seriado.
- C) Hemocultivo para anaerobios.
- D) Prueba de catalasa.
- E) Tinción de Gram de piel.

8. Los protozoarios se diferencian de los helmintos porque generalmente son:

- A) Pluricélulares segmentados.
- B) Artrópodos con exoesqueleto.
- C) Serpientes venenosas.
- D) Unicélulares.
- E) Hongos filamentosos.

9. Una medida de APS contra parásitosis transmitidas por suelo debe priorizar:

- A) Solo antitermicos.
- B) Vacuna SRP.
- C) Letrinas, calzado y lavado de manos.
- D) Antiveneno preventivo.
- E) Uso de lentes de sol.

10. Si un parásito necesita más de un huésped para completar su ciclo, se trata de un ciclo:

- A) Indirecto o heteroxeno.
- B) Directo o monoxeno.
- C) Aviral.
- D) Saprofito estricto.
- E) Exclusivamente mecanico.

13. Paludismo

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 2 Unidad XVI.1 Paludismo.pdf

1. La definición más completa de paludismo incluye infección por Plasmodium y transmisión habitual por:

- A) Triatominos hematofagos.
- B) Hembras de Anopheles.
- C) Flebotomos.
- D) Caracoles Lymnaea.
- E) Pulgas de perro.

2. El primer sitio de multiplicación del Plasmodium después de la inoculación vectorial es:

- A) Vejiga.
- B) Ganglio sensorial.
- C) Intestino grueso.
- D) Hígado.
- E) Vía biliar.

3. Los paroxismos febriles se relacionan principalmente con:

- A) Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.
- B) Migración de larvas por pulmón.
- C) Liberación de huevos por proglotides.
- D) Invasión de queratinocitos.
- E) Mordedura local de serpiente.

4. P. falciparum es especialmente temido porque puede producir:

- A) Solo infección leve sin complicaciones.
- B) Quistes hepáticos calcificados.
- C) Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.
- D) Verrugas genitales.
- E) Parotiditis viral.

5. La gota gruesa y el extendido fino sirven respectivamente para:

- A) Medir anticuerpos y vacunar.
- B) Buscar huevos y larvas.
- C) Identificar veneno y necrosis.
- D) Detectar quistes y ooquistes felinos.
- E) Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.

6. Una prueba rápida de malaria busca principalmente:

- A) Anticuerpos antirrábicos.
- B) Antígenos parasitarios.
- C) Huevos operculados.
- D) Cuerpos de inclusión nuclear.
- E) Toxinas de serpiente.

7. Las recaídas por hipnozoitos se asocian sobre todo con:

- A) P. falciparum y P. malariae.
- B) T. cruzi y T. rangeli.
- C) Leishmania donovani y infantum.
- D) P. vivax y P. ovale.
- E) Giardia y Trichomonas.

8. La transmisión no vectorial del paludismo puede ocurrir por:

- A) Inhalación de polvo con huevos.
- B) Contacto con verrugas.
- C) Transplacentaria o transfusional.
- D) Mordedura de gato.
- E) Carne de pescado cruda.

9. La certificación de Paraguay como país libre de malaria autóctona implica:

- A) Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.
- B) Ausencia mundial de malaria.
- C) Eliminación de mosquitos de todo el país.
- D) Inutilidad de todo diagnóstico en viajeros.
- E) Erradicación de Plasmodium en Brasil.

10. Una medida preventiva primaria contra paludismo es:

- A) Evitar gatos durante embarazo.
- B) Cocinar carne de cerdo.
- C) Lavar heridas por mordedura.
- D) Observar perros por 10 días.
- E) Control vectorial y protección contra picaduras.

14. Trypanosoma

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 3 Unidad XVI.2 Trypanosoma.pdf

1. La enfermedad de Chagas se produce por:

- A) Trypanosoma brucei gambiense.
- B) Trypanosoma rangeli exclusivamente.
- C) Leishmania infantum.
- D) Trypanosoma cruzi.
- E) Plasmodium falciparum.

2. El mecanismo vectorial principal de Chagas ocurre cuando:

- A) Heces de triatomino contaminan piel lesionada o mucosas.
- B) La vinchuca inocular larvas por saliva siempre.
- C) El mosquito Anopheles deposita ooquistes.
- D) El caracol libera cercarias al agua.
- E) La pulga transmite proglotides.

3. La forma intracélular tisular de T. cruzi es:

- A) Ooquiste.
- B) Metacercaria.
- C) Amastigote.
- D) Plerocercario.
- E) Hipnozoito.

4. En sangre periférica durante fase aguda de Chagas se puede buscar:

- A) Huevos mamelonados.
- B) Quistes hidatídicos.
- C) Cercarias.
- D) Pentonas.
- E) Tripomastigotes.

5. El signo de Romana se relaciona con:

- A) Ulceración nasal mucocutánea.
- B) Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.
- C) Vesículas en dermatoma.
- D) Mordedura de serpiente coral.
- E) Diarrea por Giardia.

6. En la fase crónica de Chagas, una complicación clásica es:

- A) Bronquiolitis por sincitios.
- B) Condiloma acuminado.
- C) Anemia megaloblástica por pescado.
- D) Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.
- E) Hidrofobia.

7. Otra manifestación digestiva crónica de Chagas es:

- A) Colitis por huevos de Schistosoma.
- B) Ictericia por Fasciola.
- C) Megaesófago o megacolon.
- D) Enteritis por rotavirus.
- E) Apendicitis por Ascaris.

8. Para diagnóstico crónico de Chagas se prefiere:

- A) Serología con pruebas diferentes.
- B) Gota gruesa única.
- C) Cinta adhesiva perianal.
- D) Cultivo de garganta.
- E) Papanicolaou.

9. Trypanosoma rangeli es importante porque:

- A) Produce siempre cardiopatía mortal.
- B) Es transmitido por Anopheles.
- C) Genera quistes musculares.
- D) Causa sarcoma de Kaposi.
- E) Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.

10. La tripanosomiasis africana se asocia con:

- A) T. cruzi y vinchuca.
- B) T. brucei y mosca tsetse.
- C) Leishmania y flebotomo.
- D) Plasmodium y Anopheles.
- E) Toxoplasma y gato.

15. Toxoplasma gondii

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 4 Unidad XVI Toxoplasma.pdf

1. El hospedador definitivo de Toxoplasma gondii es:

- A) Felino.
- B) Humano.
- C) Mosquito.
- D) Caracol.
- E) Pez.

2. La forma invasiva y proliferativa de la fase aguda se denomina:

- A) Ooquiste esporulado.
- B) Bradyzoito tisular.
- C) Trofozoíto/taquizoíto.
- D) Metacercaria.
- E) Proglotide.

3. Los quistes tisulares con bradizoitos se relacionan principalmente con:

- A) Fase sexual en gato únicamente.
- B) Eliminación por orina humana.
- C) Picadura de flebotomo.
- D) Huevos en vías biliares.
- E) Fase crónica y transmisión por carne.

4. Una vía frecuente de infección humana por T. gondii es:

- A) Mordedura de perro rabioso.
- B) Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.
- C) Picadura de vinchuca.
- D) Cercarias en agua dulce.
- E) Pescado con plerocercario.

5. La transmisión congénita ocurre cuando:

- A) El padre tiene verrugas cutáneas.
- B) El recién nacido ingiere pescado crudo.
- C) Hay mordedura de serpiente en parto.
- D) La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.
- E) Existe contacto con piojos.

6. La triada congénita clásica incluye:

- A) Parotiditis, orquitis y meningitis.
- B) Tos, fiebre y bronquiolitis.
- C) Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.
- D) Diarrea, meteorismo y esteatorrea.
- E) Hematuria, fibrosis vesical y cáncer.

7. En pacientes con VIH avanzado, la reactivación de toxoplasmosis suele causar:

- A) Encefalitis con lesiones cerebrales.
- B) Condilomas anogenitales.
- C) Colitis por huevos.
- D) Crisis aplásica pura.
- E) Parálisis diafrágica por veneno.

8. Para interpretar infección reciente en embarazada, es útil valorar:

- A) Cinta adhesiva perianal.
- B) Gota gruesa y gota fina.
- C) Cultivo de caracol.
- D) Prueba de coagulasa.
- E) IgM, IgG y avididad de IgG.

9. Una medida preventiva en gestantes seronegativas es:

- A) Suspender toda vacunación SRP ya recibida.
- B) Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.
- C) Tomar antiveneno mensual.
- D) Consumir pescado crudo congelado.
- E) Caminar descalza para inmunizarse.

10. El ooquiste de Toxoplasma eliminado por felinos se vuelve importante porque:

- A) Se transforma en adulto en vía biliar.
- B) Penetra piel como larva filariforme.
- C) Forma cápside viral icosaédrica.
- D) Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.
- E) Produce vitamina B12.

16. Leishmania

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 5 Unidad XVI Leishmania.pdf

1. La forma infectante para el humano en Leishmania transmitida por flebotomo es:

- A) Amastigote intracélular.
- B) Ooquiste esporulado.
- C) Promastigote metacíclico.
- D) Cercaria acuática.
- E) Huevo embrionado.

2. Dentro del humano, Leishmania se multiplica principalmente como:

- A) Tripomastigote en eritrocitos.
- B) Merozoito en hepatocitos.
- C) Larva filariforme en piel.
- D) Procercoide en crustaceos.
- E) Amastigote en macrofagos.

3. El vector más relacionado con leishmaniasis es:

- A) Anopheles.
- B) Flebotomo.
- C) Triatomino.
- D) Caracol Lymnaea.
- E) Pulga.

4. La leishmaniasis visceral se caracteriza mejor por:

- A) Verrugas genitales y coilocitosis.
- B) Diarrea grasa sin invasión.
- C) Hidrofobia y encefalitis.
- D) Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.
- E) Prurito anal nocturno.

5. En la leishmaniasis visceral americana, un reservorio doméstico clave es:

- A) Gato como definitivo.
- B) Pez de agua dulce.
- C) Perro.
- D) Cerdo exclusivamente.
- E) Caracol.

6. La forma mucocutánea es preocupante porque puede producir:

- A) Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.
- B) Aplasia eritroide pura.
- C) Parálisis flácida poliomielítica.
- D) Quistes en cerebro por huevos.
- E) Bronquiolitis infantil.

7. Un diagnóstico parasitológico directo de leishmaniasis busca:

- A) Huevos mamelonados en heces.
- B) Cercarias en piel.
- C) Ooquistes ácido-alcohol resistentes.
- D) Antígenos de influenza.
- E) Amastigotes en material de lesión o médula.

8. La coinfección con VIH en leishmaniasis visceral se considera grave porque:

- A) Impide toda transmisión vectorial.
- B) Aumenta mortalidad y dificulta manejo.
- C) Convierte al parásito en virus.
- D) Elimina necesidad de tratamiento.
- E) Produce inmunidad esterilizante.

9. Una medida preventiva comunitaria correcta es:

- A) Solo clorar agua sin otras medidas.
- B) Vacunar contra HPV.
- C) Observar perros mordedores 10 días.
- D) Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.
- E) Cocinar pescado de río.

10. La leishmaniosis se considera enfermedad desatendida porque:

- A) Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.
- B) Solo ocurre en países ricos.
- C) No requiere vector ni reservorio.
- D) Nunca causa daño clínico.
- E) Se erradica mundialmente.

17. Protozoarios intestinales y urogenitales

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 6 Unidad XVII Protozoarios intestinales y urogenitales.pdf

1. En amebas intestinales, la forma quística se caracteriza por ser:

- A) Siempre móvil e invasiva.
- B) Exclusiva de sangre.
- C) Transmitida por flebotomo.
- D) Un estadio de helminto.
- E) Resistente e infecciosa.

2. En *Entamoeba histolytica*, los trofozoitos se observan mejor en:

- A) Heces formadas antiguas.
- B) Heces recientes.
- C) Sangre seca.
- D) Esputo estéril.
- E) Orina matinal.

3. La presencia de trofozoitos con eritrocitos ingeridos orienta a:

- A) *Entamoeba coli* comensal.
- B) *Giardia* no invasiva.
- C) *Trichomonas vaginalis*.
- D) *Entamoeba histolytica* invasiva.
- E) *Cryptosporidium*.

4. *Giardia lamblia* produce malabsorción porque se localiza sobre todo en:

- A) Colon sigmoide exclusivo.
- B) Vías biliares adultas.
- C) Duodeno y yeyuno proximal.
- D) Ganglios sensitivos.
- E) Médula ósea.

5. Un cuadro de diarrea palida, fetida, meteorismo y pérdida de peso sugiere:

- A) Giardiasis.
- B) Rabia.
- C) Sarcoma de Kaposi.
- D) Parotiditis.
- E) Crotalismo.

6. *Trichomonas vaginalis* se diferencia de muchos protozoos intestinales porque:

- A) Forma huevos embrionados en suelo.
- B) Tiene reservorio felino definitivo.
- C) Necesita caracol intermediario.
- D) Es un virus de ARN.
- E) No tiene fase quística y se transmite sexualmente.

7. *Balantidium coli* se asocia epidemiológicamente con:

- A) Gatos y toxoplasmosis.
- B) Cerdos y cuadros disentéricos.
- C) Perros y hidatidosis.
- D) Mosquitos y dengue.
- E) Peces y B12 baja.

8. *Cryptosporidium* causa especial gravedad en:

- A) Adultos sanos con verrugas comunes.
- B) Pacientes con mordedura ofídica.
- C) Pescadores con anemia megaloblástica.
- D) Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.
- E) Gestantes vacunadas contra rubéola.

9. El diagnóstico de giardiasis puede apoyarse en:

- A) Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.
- B) Cuerpos de Negri en cerebro.
- C) Huevos en vía biliar.
- D) Serología de Chagas crónico.
- E) Prueba de neutralización de veneno.

10. La prevención de protozoarios intestinales prioriza:

- A) Solo repelente contra flebotomos.
- B) Vacuna SRP en adultos.
- C) Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.
- D) Cocinar carne de res.
- E) Antiveneno en puestos de salud.

18. Nematodos intestinales

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 7 Unidad XVIII Nematodos intestinales.pdf

1. La forma infectante de *Ascaris lumbricoides* para el humano es:

- A) Larva filariforme penetrante.
- B) Huevo embrionado ingerido.
- C) Cisticerco en carne.
- D) Metacercaria en vegetal acuático.
- E) Plerocercario en pescado.

2. El síndrome de Loeffler en ascariosis se relaciona con:

- A) Adultos en vías biliares siempre.
- B) Huevos en vejiga.
- C) Cisticercos cerebrales.
- D) Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.
- E) Toxina neurotrópica salival.

3. La obstrucción intestinal por *Ascaris* se observa sobre todo cuando:

- A) Solo hay un huevo no fecundado.
- B) El parásito está en mosquito.
- C) Existe alta carga de vermes adultos.
- D) El paciente fue vacunado contra polio.
- E) La infección es por *Trichomonas*.

4. *Trichuris trichiura* se asocia en infección intensa con:

- A) Prolapso rectal y anemia.
- B) Hidrofobia.
- C) Condiloma acuminado.
- D) Fiebre amarilla.
- E) Quiste hidatídico.

5. *Enterobius vermicularis* se diagnostica mejor mediante:

- A) Gota gruesa.
- B) Biopsia hepática.
- C) Aspirado de médula ósea.
- D) PCR respiratoria.
- E) Cinta adhesiva perianal matinal.

6. El prurito anal nocturno en un niño orienta principalmente a:

- A) Fasciolosis.
- B) Oxiuriasis.
- C) Dengue.
- D) Rabia.
- E) Leishmaniasis visceral.

7. *Strongyloides stercoralis* preocupa en inmunodeprimidos porque puede producir:

- A) Cáncer cervical.
- B) Aplasia eritroide por B19.
- C) Mononucleosis.
- D) Autoinfección e hiperinfección.
- E) Zoster localizado.

8. Uncinarias como *Ancylostoma* y *Necator* ingresan habitualmente por:

- A) Penetración cutánea de larvas filariformes.
- B) Ingestión de carne bovina cruda.
- C) Picadura de triatoma.
- D) Oocistos de gato.
- E) Mordedura de serpiente.

9. La anemia por uncinarias se debe principalmente a:

- A) Deficit de B12 por pescado.
- B) Hemolisis por malaria grave.
- C) Perdida crónica de sangre intestinal.
- D) Aplasia por parvovirus.
- E) Destruccion medular por VIH.

10. Toxocara sp. en humanos se manifiesta como:

- A) Teniasis intestinal adulta.
- B) Diarrea acuosa por coccidios.
- C) Verrugas por HPV.
- D) Parotiditis.
- E) Larva migrans visceral u ocular.

19. Cestodos

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 8 Unidad XIX.1 Cestodos_692844f23847639fcf5f2caca60630ff.pdf

1. *Diphyllobothrium latum* se adquiere por ingestión de:

- A) Carne de cerdo con bradizoitos.
- B) Berro con metacercarias.
- C) Agua con cercarias.
- D) Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.
- E) Huevos en polvo domiciliario.

2. Una complicación clásica de *Diphyllobothrium latum* es:

- A) Hidrofobia y encefalitis.
- B) Condilomas genitales.
- C) Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblástica.
- D) Insuficiencia respiratoria por RSV.
- E) Crisis aplásica por B19.

3. *Taenia saginata* se relaciona con:

- A) Carne bovina con cisticercos.
- B) Carne porcina con huevos embrionados.
- C) Pescado con plerocercoides.
- D) Perro con quiste hidatídico adulto.
- E) Caracol con cercarias.

4. La neurocisticercosis ocurre cuando el humano ingiere:

- A) Cisticercos de *Taenia saginata*.
- B) Plerocercoides de pescado.
- C) Metacercarias de *Fasciola*.
- D) Ooquistes de *Cryptosporidium*.
- E) Huevos de *Taenia solium*.

5. La teniasis intestinal por *T. solium* se adquiere por:

- A) Ingestión de huevos de *T. solium*.
- B) Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.
- C) Picadura de flebotomo.
- D) Mordedura de perro.
- E) Agua con cercarias.

6. *Hymenolepis nana* es particular porque:

- A) Necesita siempre pescado y copépodo.
- B) Solo infecta perros.
- C) No produce huevos.
- D) Puede completar ciclo directo y autoinfectar.
- E) Es un trematodo hepático.

7. *Dipylidium caninum* se transmite al humano, especialmente niños, por:

- A) Ingestión accidental de pulgas infectadas.
- B) Picadura de Anopheles.
- C) Carne bovina mal cocida.
- D) Berro contaminado.
- E) Heces de gato con ooquistes.

8. En *Echinococcus granulosus*, el humano actúa como:

- A) Huesped definitivo principal.
- B) Vector biológico.
- C) Huesped intermediario accidental.
- D) Reservorio felino.
- E) Caracol intermediario.

9. El perro en *Echinococcus granulosus* alberga principalmente:

- A) Quistes hidatídicos hepáticos.
- B) Cisticercos musculares.
- C) Huevos operculados biliares.
- D) Larvas pulmonares de *Ascaris*.
- E) Adultos intestinales.

10. El diagnóstico de hidatidosis se apoya más en:

- A) Cinta adhesiva perianal.
- B) Imágenes y serología según localización.
- C) Gota gruesa.
- D) Papanicolaou.
- E) Cultivo viral.

20. Trematodos

Parasitología · 10 preguntas · Fuente: 9 Unidad XIX.2 Trematodos.pdf

1. Fasciola hepática utiliza como hospedador intermediario a:

- A) Mosquitos Aedes.
- B) Pulgas de perro.
- C) Caracoles del genero Lymnaea.
- D) Peces de agua dulce.
- E) Gatos domesticos.

2. La forma infectante de Fasciola para el humano es:

- A) Metacercaria en vegetacion acuática.
- B) Cercaria que penetra piel.
- C) Huevo embrionado en suelo.
- D) Plerocercoides en pescado.
- E) Cisticercos en cerdo.

3. Los adultos de Fasciola hepática se localizan principalmente en:

- A) Colon.
- B) Ganglios sensoriales.
- C) Medula osea.
- D) Vejiga urinaria exclusivamente.
- E) Vias biliares.

4. Los huevos de Fasciola son eliminados al exterior por:

- A) Saliva.
- B) Heces.
- C) Orina siempre.
- D) Sudor.
- E) Semen.

5. En la fase aguda de fasciolosis predomina:

- A) Latencia neuronal.
- B) Bronquiolitis viral.
- C) Autoinfección intestinal.
- D) Migración hepática, dolor y eosinofilia.
- E) Cisticercosis muscular.

6. Schistosoma se diferencia de Fasciola porque su cercaria:

- A) Penetra activamente la piel.
- B) Se ingiere en berros.
- C) Esta en carne de cerdo.
- D) Sale en proglotides.
- E) Permanece como quiste tisular.

7. La patología principal de esquistosomiasis se debe sobre todo a:

- A) Toxina preformada en alimentos.
- B) Replicación en queratinocitos.
- C) Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.
- D) Destrucción de eritrocitos por B19.
- E) Veneno neurotóxico.

8. Schistosoma mansoni se asocia principalmente con:

- A) Hematuria terminal exclusiva.
- B) Crisis aplásica.
- C) Exantema súbito.
- D) Condilomas.
- E) Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.

9. Schistosoma haematobium se relaciona con:

- A) Anemia por B12.
- B) Hematuria y riesgo de cáncer vesical.
- C) Quistes hepaticos grandes.
- D) Meningitis aseptica viral.
- E) Tos por rinovirus.

10. Los huevos de trematodos hepaticos clasicos como Fasciola suelen ser:

- A) Mamelonados de Ascaris.
- B) Con espina lateral siempre.
- C) Segmentados en proglotides.
- D) Grandes y operculados.
- E) Acido-alcohol resistentes.

21. Artrópodos de importancia médica

Artrópodos · 10 preguntas · Fuente: 10 Unidad XX Artrópodos.pdf

1. Una característica general de los artrópodos es:

- A) Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.
- B) Endoesqueleto oseo y pulmones alveolares.
- C) Capsidom icosaédrica y genoma ARN.
- D) Pared celular de peptidoglicano.
- E) Cuerpo plano sin apéndices.

2. Los insectos se diferencian de arácnidos porque suelen tener:

- A) Cuatro pares de patas y cefalotorax.
- B) Sin patas y cuerpo cilíndrico.
- C) Botrios en esólex.
- D) Ventosas oral y ventral siempre.
- E) Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.

3. Un vector mecánico transmite agentes principalmente por:

- A) Desarrollo obligatorio del parásito en su cuerpo.
- B) Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.
- C) Inoculación de veneno neurotóxico.
- D) Producción de huevos dentro del humano.
- E) Replicación viral en ganglio sensorial.

4. Los triatominos tienen importancia médica por transmitir:

- A) Leishmania infantum.
- B) Plasmodium vivax.
- C) Dengue virus.
- D) Trypanosoma cruzi.
- E) Fasciola hepática.

5. Los flebotomos son relevantes porque transmiten:

- A) Leishmania.
- B) Rabia.
- C) Poliovirus.
- D) Taenia saginata.
- E) Enterobius.

6. Mosquitos del género Aedes se asocian especialmente con:

- A) Chagas y leishmaniasis visceral.
- B) Hidatidosis y teniasis.
- C) Dengue, Zika, Chikungunya y fiebre amarilla urbana.
- D) Oxiuriasis y trichuriasis.
- E) Fasciolosis y esquistosomiasis.

7. La pediculosis se relaciona con infestación por:

- A) Garrapatas.
- B) Pulgas exclusivamente.
- C) Flebotomos.
- D) Cucarachas.
- E) Piojos.

8. Las garrapatas son importantes porque pueden actuar como:

- A) Hosped definitivo de Echinococcus.
- B) Vectores biológicos de varios agentes.
- C) Reservorio felino de Toxoplasma.
- D) Caracol intermediario de Fasciola.
- E) Adulto intestinal de Taenia.

9. La pulga participa en la transmisión de *Dipylidium caninum* cuando:

- A) Pica e inocula cercarias.
- B) Defeca tripomastigotes.
- C) Libera ooquistes en arena.
- D) Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.
- E) Deposita huevos de *Ascaris*.

10. Una medida general contra vectores artrópodos en APS es:

- A) Suspender agua potable.
- B) Evitar toda vacunación.
- C) Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.
- D) Usar antibióticos semanales.
- E) Capturar serpientes para estudio.

22. Importancia médica de serpientes

Serpientes · 10 preguntas · Fuente: 11 Unidad XXI Serpientes.pdf

1. En Sudamerica, la mayoría de accidentes ofidicos se atribuye a:

- A) Micrurus.
- B) Cobra.
- C) Dispholidus.
- D) Sistrurus exclusivamente.
- E) Bothrops.

2. En Paraguay, Bothrops tiene relevancia sanitaria porque:

- A) Es siempre no venenosa.
- B) Incluye especies capaces de accidentes severos.
- C) Solo causa lesiones leves locales.
- D) Pertenece a anfibios.
- E) No existe en el país.

3. Un accidente bothropico se caracteriza inicialmente por:

- A) Paralisis sin lesion local ni coagulopatía.
- B) Diarrea crónica y malabsorción.
- C) Hidrofobia y fiebre.
- D) Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.
- E) Exantema y artralgia.

4. El veneno crotalico se asocia más con:

- A) Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.
- B) Verrugas cutaneas.
- C) Diarrea acuosa por enterocito.
- D) Quistes hepaticos.
- E) Anemia megaloblastica.

5. Las serpientes coral del genero Micrurus producen principalmente:

- A) Cuadro biliar crónico.
- B) Colitis disintérica.
- C) Cuadro neurotoxico.
- D) Bronquiolitis.
- E) Mononucleosis.

6. La conducta prehospitalaria adecuada tras mordedura sospechosa incluye:

- A) Torniquete apretado prolongado.
- B) Cortes y succión de la herida.
- C) Aplicar hielo directo por horas.
- D) Dar alcohol para analgesia.
- E) Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.

7. El tratamiento específico de un envenenamiento ofidico moderado o severo es:

- A) Antiviral de amplio espectro.
- B) Suero antiofidico indicado segun tipo y gravedad.
- C) Albendazol por 3 días.
- D) Vacuna SRP de urgencia.
- E) Antihistaminico como unica medida.

8. Para decidir gravedad y seguimiento, que estudios son más pertinentes?

- A) Papanicolau y colposcopia.
- B) Gota gruesa y gota fina exclusivamente.
- C) Coprocultivo de rutina.
- D) Coagulación, hemograma, función renal y evaluación local.
- E) Serología de VEB.

9. Ante una mordedura, la identificación de la serpiente debe:

- A) Ser obligatoria antes de todo tratamiento.
- B) Realizarse capturando siempre el animal vivo.
- C) Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.
- D) Sustituir la evaluación clínica.
- E) Evitar el uso de antiveneno.

10. La importancia de la guía nacional de accidentes ofídicos se relaciona con:

- A) Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.
- B) Eliminar todos los reptiles del país.
- C) Diagnosticar virosis respiratorias.
- D) Tratar parasitosis intestinales.
- E) Reemplazar vacunación humana.

Gabarito simple

Letra correcta y texto de la alternativa correcta. Organizado por bloque para facilitar revisión rápida.

1. Generalidades de Virología

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	C	Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos.
2	A	Capside desnuda proteica.
3	E	Nucleocapside.
4	B	PCR o RT-PCR.
5	D	Mayor sensibilidad a detergentes.
6	A	Citolisis viral.
7	C	Envoltura - sensibilidad a solventes lipidicos.
8	E	Es un parásito intracélular obligado.
9	B	Liberacion del genoma viral.
10	D	Vías epidemiologicas de virus estudiados.
11	A	Contienen ADN o ARN, pero no ambos tipos de ácido nucleico.
12	A	Nanómetros (nm)
13	D	El ácido nucleico asociado a la cápside proteica.
14	A	Núcleo
15	C	Periodo de latencia
16	D	La integración o persistencia del virus que induce una proliferación celular descontrolada.
17	C	Gemación
18	D	Orthomyxoviridae
19	C	RT-PCR (PCR con transcriptasa inversa)
20	B	Adenovirus
21	C	Pródromos

2. Herpesvirus: VHS, VVZ, VEB, CMV, VHH-6, VHH-7 y VHH-8

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	A	Latencia en ganglios sensoriales.
2	E	Piel o mucosa lesionada.
3	B	Replicación del ADN viral.
4	D	Primoinfección respiratoria, latencia y reactivacion.
5	A	Establecer infección persistente de por vida.
6	C	Pueden producir morbilidad significativa.
7	E	Celulas gigantes multinucleadas.
8	B	Neurona de ganglio sensorial.
9	D	Comparten características, pero difieren en patrones clinicos frecuentes.
10	C	PCR para ADN viral.
11	E	Virus Epstein-Barr.
12	B	Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados.
13	D	Linfocito B.
14	A	Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.
15	C	Exantema subito.
16	E	Sarcoma de Kaposi.
17	B	Infeccion materna y daño fetal compatible.

N°	Letra	Respuesta correcta
18	D	Inclusiones intranucleares en ojo de buho.
19	C	Citomegalovirus.
20	A	VEB - saliva - linfocito B.
21	D	Linfocitos B
22	B	Una respuesta inmunitaria hiperactiva de los linfocitos T
23	C	Linfocitos T con citoplasma basófilo y vacuolado con núcleo ovalado
24	A	Linfadenopatía, esplenomegalia y faringitis exudativa
25	A	Leucoplasia vellosa oral
26	C	Semen
27	B	Célula citomegálica con cuerpo de inclusión intranuclear en 'ojo de búho'
28	B	Citomegalovirus (CMV)
29	B	Monocitos y linfocitos
30	A	Neumonía y hepatitis
31	C	VHH-6B y VHH-7
32	D	Convulsiones febriles
33	D	Llagas pequeñas ligeramente elevadas de color rosa sin prurito
34	C	Favorecer el contacto temprano ya que la enfermedad es benigna o subclínica en niños
35	D	Sondas de ADN y PCR
36	B	Síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis
37	A	Niños en África con malaria
38	C	Cuadro crónico
39	C	La infección primaria es extremadamente grave para el feto
40	D	Secreciones bucales (saliva y aerosoles)
41	D	Pacientes con SIDA
42	A	La mayoría de los adultos
43	B	La mononucleosis por CMV es negativa a anticuerpos heterófilos
44	B	Pueden padecer una enfermedad policlonal de linfocitos B potencialmente mortal
45	A	Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes y vasos

3. Papilomavirus

N°	Letra	Respuesta correcta
1	B	ADN circular bicatenario sin envoltura.
2	D	Papilomavirus humano.
3	A	Queratinocito infectado.
4	C	HPV 16/18 - cáncer cervical.
5	C	Displasia, neoplasia cervical y cáncer de cuello uterino.
6	B	HPV mucoso de bajo riesgo.
7	D	Contacto sexual directo.
8	C	La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.
9	A	Vacunación contra tipos oncogénicos.
10	E	Koilocitosis.
11	B	ADN circular bicatenario
12	C	Estrato espinoso
13	C	Koilocitos
14	A	VPH-6 y VPH-11

Nº	Letra	Respuesta correcta
15	C	Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
16	D	99,7%
17	A	Crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales
18	A	Anual
19	A	No puede tratar ni curar una infección ya existente
20	A	Tabaquismo
21	B	Ojo de gallo
22	B	VPH–16 y VPH–18
23	B	El virus permanece en los queratinocitos sin producir síntomas visibles
24	D	Autoinoculación
25	A	Posible obstrucción de las vías respiratorias
26	A	30 al 60%
27	A	Hiperplasia de células espinosas e hiperqueratosis
28	C	Hasta 3 o 4 meses
29	B	Cutáneos o mucosos
30	B	Cáncer de pene, ano y orofaringe
31	A	Para evitar el dolor, motivos estéticos y prevenir la autoinoculación
32	D	La respuesta inmunitaria del hospedador
33	B	Displasia moderada

4. Adenovirus

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	D	ADN bicatenario lineal, sin envoltura.
2	A	Hexonas, pentonas y fibras.
3	C	Núcleo celular.
4	E	Conjuntivitis.
5	B	Adenovirus.
6	D	Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.
7	C	Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos.
8	A	Lisis celular.
9	E	Células linfoides y adenoides.
10	B	Virus ADN sin envoltura resistente.
11	A	Células de adenoides
12	D	ADN bicatenario lineal
13	D	Núcleo
14	B	Hexonas, pentonas y fibras
15	D	Procesos de replicación y ensamblaje ineficaces
16	B	Infección latente
17	B	Los anticuerpos no confieren protección contra serotipos diferentes al de la infección original
18	C	Resistencia a la desecación, detergentes y cloro leve
19	A	Tipos 1, 2, 5 y 6
20	D	Tipos 4 y 7
21	B	Fiebre faringoconjuntival
22	D	La presencia de dolor en la queratoconjuntivitis
23	B	Serotipos 40 y 41

Nº	Letra	Respuesta correcta
24	B	Cistitis hemorrágica aguda
25	B	PCR y análisis de sondas de ADN
26	A	No existe un tratamiento específico aprobado
27	A	Cloración adecuada de las piscinas
28	B	Personal militar
29	C	Vectores para vacunas contra el Ebola y Covid-19
30	C	Cuando ha finalizado la replicación del ADN
31	C	Lisis celular

5. Parvovirus y Poxvirus

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	A	ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.
2	C	Celulas precursoras eritroides.
3	E	Parvovirus B19.
4	B	Mediados por respuesta inmunitaria.
5	D	Viremia y secreciones respiratorias.
6	C	Hidropesia fetal por anemia.
7	A	Replica en el citoplasma.
8	E	Grandes, complejos y de ADN bicatenario.
9	B	Vaccinia.
10	D	Poxvirus.
11	D	Son los virus de ADN de menor tamaño y poseen ADN monocatenario lineal.
12	D	La síntesis de una cadena complementaria para formar ADN bicatenario.
13	D	Una intensa viremia y la destrucción lítica de precursores eritroides.
14	A	Porque el exantema es una manifestación inmunológica posterior a la viremia.
15	D	Poliartritis y artralgias que pueden durar semanas o meses.
16	B	Crisis aplásica debida al agotamiento de precursores eritrocitarios.
17	C	Riesgo de muerte fetal por anemia e insuficiencia cardíaca (hidropesía fetal).
18	C	El bocavirus se asocia con enfermedades respiratorias y se transmite también por las heces.
19	A	En el citoplasma.
20	B	La erupción de pústulas características en la piel y mucosas.
21	C	Se encuentra en animales (monos, ardillas) y es una zoonosis.
22	D	Nódulos umbilicados con un tapón caseoso central.
23	A	Presencia de grandes inclusiones citoplásmicas eosinofílicas (cuerpos de Molluscum).
24	A	Por contacto directo con lesiones de animales infectados (ovejas, vacas).
25	C	Bocavirus.
26	B	El lavado de manos y el uso de tapabocas ayudan a prevenir la diseminación.
27	B	La exposición a la luz solar, calor o ejercicio físico.
28	C	Cuando las lesiones se han cubierto de costras, estas han caído y hay piel nueva debajo.
29	B	La respuesta inmunitaria y el depósito de complejos antígeno-anticuerpo.
30	C	Seudoviruela bovina.
31	B	Porque el B19 produce síntomas diferentes según la edad (artritis en adultos vs exantema en niños).
32	B	Ambos son virus cuyo material genético principal es el ADN.
33	A	Raspado (curetaje), nitrógeno líquido o soluciones de yodo.
34	A	Entre el 15% y el 40%.

N°	Letra	Respuesta correcta
35	B	Fiebre, escalofríos, malestar y mialgias.
36	D	En la cavidad bucal.
37	D	Enfermedad crónica por incapacidad de aclarar la viremia.
38	B	La necesidad de polimerasas de ADN celulares que solo se expresan durante la división.

6. Picornavirus

N°	Letra	Respuesta correcta
1	C	ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.
2	E	No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.
3	B	Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.
4	D	Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.
5	C	Neuronas motoras del asta anterior.
6	A	Herpangina y mano-pie-boca.
7	E	Miocarditis y pleurodinia.
8	B	Citoplasma de la célula.
9	D	Enterovirus.
10	A	Vacunación.
11	B	Los Rinovirus son lábiles al pH ácido, mientras que los Enterovirus son resistentes a un rango de pH de 3 a 9.
12	A	Porque normalmente no provocan enfermedades entéricas, a pesar de transmitirse por vía fecal-oral.
13	A	La viremia secundaria que distribuye el virus al tejido diana.
14	A	90%
15	A	Tipo 1
16	D	Parálisis flácida asimétrica sin pérdida sensorial.
17	B	El grupo A se asocia frecuentemente con lesiones vesiculares, mientras que el grupo B causa miocarditis y pleurodinia.
18	C	Herpangina
19	B	Coxsackievirus grupo B
20	C	Echovirus 11
21	C	Líquido cefalorraquídeo (LCR)
22	C	Debido a su mejor perfil de seguridad al eliminar el riesgo de poliomiелitis asociada a la vacuna.
23	D	Riesgo de diseminación del virus atenuado a personas próximas no vacunadas.
24	C	La temperatura de 33 °C de las vías respiratorias superiores.
25	C	Lavado de manos frecuente y desinfección de objetos contaminados.
26	D	1 y 35 días.
27	A	La localización y el número de neuronas motoras destruidas por el virus.
28	A	6 meses a 2 años.
29	B	Fiebre e insuficiencia cardíaca.
30	B	Distinguir rápidamente una meningitis por Enterovirus de una meningitis bacteriana.
31	B	Falso
32	A	Hepatovirus
33	A	El virus se replica íntegramente en el citoplasma de la célula huésped.
34	A	Coxsackie A16

7. Orthomixovirus y Reovirus

N°	Letra	Respuesta correcta
1	E	Ocho segmentos de ARN y envoltura.
2	B	Deriva antigenica.
3	D	Influenza A.
4	C	Hemaglutinina y neuraminidasa.
5	A	Liberacion de nuevos viriones.
6	E	Reorganizacion entre cepas humanas y animales.
7	B	RT-PCR de muestra respiratoria.
8	D	ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.
9	A	Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.
10	C	Vacunacion oral.
11	C	Los virus A y B poseen 8 segmentos de ARN, mientras que el C posee 7.
12	B	El salto antigénico (reorganización) en el virus de la gripe A.
13	A	Núcleo.
14	D	Unirse a receptores de ácido siálico y facilitar la fusión de membranas.
15	D	Respuestas de interferón y citocinas.
16	C	No deben recibir la vacuna convencional, aunque existen alternativas sin proteínas de huevo.
17	C	ARN bicatenario segmentado y carencia de envoltura.
18	C	Proteólisis de la cápside externa para formar una partícula subviral intermedia.
19	C	Atrofia y aplanamiento de las microvellosidades del intestino delgado.
20	C	PCR.
21	C	Síndrome de Guillain-Barré.
22	D	Porque no experimenta saltos antigénicos por no infectar animales comúnmente.
23	D	1 a 4 días.
24	C	Las variantes de las glucoproteínas Hemaglutinina y Neuraminidasa.
25	C	Por gemación a través de la membrana plasmática.
26	D	Reviste el interior de la envoltura y favorece el ensamblaje.
27	D	Lactantes y niños pequeños.
28	B	Vía fecal-oral.
29	D	Deriva antigénica.
30	D	Actúa como una enterotoxina que induce la secreción de calcio y cloruro.
31	A	Infecta al ganado vacuno, pero no se sabe si causa enfermedad en humanos.
32	D	Pérdida de la función ciliar y descamación de células epiteliales.
33	A	El número de orden del aislamiento local.

8. Paramixovirus

N°	Letra	Respuesta correcta
1	B	ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.
2	D	Celulas gigantes multinucleadas por fusion.
3	C	Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.
4	A	Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.
5	E	Crup o laringotraqueobronquitis.
6	B	Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.
7	D	Lactantes con bronquiolitis.
8	A	Fusion de membranas y sincitios.
9	C	Triple viral o SRP/MMR.

Nº	Letra	Respuesta correcta
10	E	Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.
11	D	Virión grande con ARN(-) monocatenario en una nucleocápside helicoidal y posee envoltura.
12	D	En el citoplasma celular.
13	A	Ácido siálico de los glucolípidos de la superficie celular.
14	B	Sincitios.
15	C	Las gotitas respiratorias pueden quedar suspendidas en el aire hasta 2 horas.
16	A	Manchas de Koplik.
17	B	La respuesta de los linfocitos T frente a las células endoteliales infectadas.
18	C	Neumonía.
19	B	Células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión citoplásmicos.
20	D	Sarampión, Paperas y Rubéola.
21	C	Parainfluenza no causa viremia ni produce enfermedades sistémicas.
22	B	Laringotraqueobronquitis (Crup).
23	C	Inhalación de vapores fríos o calientes.
24	A	Testículos, ovarios, páncreas y sistema nervioso central.
25	B	Esterilidad o infertilidad por atrofia testicular.
26	D	Debido a la infección y daño directo de las células del páncreas.
27	B	Dura toda la vida.
28	C	Virus Respiratorio Sincitial (VRS).
29	D	Obstrucción por tapones de mucosidad, fibrina y material necrótico.
30	C	Casi siempre en invierno, todos los años.
31	C	RT-PCR.
32	C	Niños pequeños, adultos mayores e inmunocomprometidos.
33	D	Facilitar el ensamblaje y revestir la cara interna de la envoltura.
34	A	El ser humano es su principal hospedador.
35	C	Antes y después de la aparición de los síntomas.
36	C	Sarampión.

9. Rhabdovirus

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	D	Virion envuelto en forma de bala.
2	C	ARN monocatenario negativo.
3	A	Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.
4	E	Herida cercana al cerebro.
5	B	Transporte neural retrogrado.
6	D	10 días.
7	A	Hidrofobia, agitación, encefalitis y coma.
8	C	Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.
9	E	Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.
10	B	ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.
11	B	Morfología en forma de bala con envoltura lipídica.
12	A	Citoplasma de la célula hospedadora.
13	B	En el tejido muscular del sitio de inoculación.
14	D	De 60 a 365 días.
15	A	La proximidad de la herida al cerebro.

Nº	Letra	Respuesta correcta
16	A	Es nula durante el transcurso de la infección.
17	A	Porque los anticuerpos no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está establecido.
18	C	Murciélago hematófago (Desmodus rotundus).
19	D	Al dolor intenso que sienten al intentar tragar agua.
20	B	Agregados de nucleocápsides víricas; aparecen en el 70%-90% de los casos.
21	C	RT-PCR.
22	D	Lavar profundamente la herida con agua y jabón.
23	B	Vacuna de virus muertos combinada con inmunoglobulina antirrábica humana.
24	A	10 días.
25	C	Fobias al viento y a movimientos bruscos.
26	C	Trasplante de tejidos infectados, como la córnea.
27	A	Insertadas en la envoltura lipídica externa.
28	B	Parálisis que origina insuficiencia respiratoria.
29	A	Si se analiza al animal y se demuestra que no presenta la infección.
30	B	Gotear o infiltrar suero antirrábico alrededor de la herida.

10. Togavirus y Flavivirus

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	C	ARN monocatenario positivo con envoltura.
2	A	Citoplasma.
3	E	Mosquito hembra hematofago.
4	B	Potenciación dependiente de anticuerpos.
5	D	NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.
6	A	Fiebre con artralgias intensas y persistentes.
7	C	Síndrome congénito y microcefalia.
8	E	Vacuna viva atenuada y control vectorial.
9	B	Rubivirus.
10	D	Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.
11	B	Hospedador terminal
12	B	Ictericia con coloración amarilla de piel y ojos
13	B	Tratamiento de soporte con líquidos y paracetamol
14	D	Determinación de anticuerpos IgM
15	D	Su modo de transmisión respiratoria
16	B	Presencia de anticuerpos no neutralizantes
17	B	Aedes aegypti
18	D	Disfunción renal y hemorragias
19	C	Trombocitopenia
20	D	3 a 6 días
21	D	Si presenta fiebre justo al momento del parto o días antes
22	C	Grupo sanguíneo del hospedador
23	C	Icosaédrica
24	D	Persistente
25	D	RT-PCR
26	C	Chikungunya
27	D	Hígado, bazo y ganglios linfáticos

N°	Letra	Respuesta correcta
28	B	Eliminación de vectores y sus zonas de reproducción
29	A	Exantema, uno de los cinco clásicos de la infancia
30	D	Monos

11. Retrovirus

N°	Letra	Respuesta correcta
1	A	Transcriptasa inversa.
2	E	ARN monocatenario positivo con envoltura.
3	B	Incorporar el ADN proviral al genoma celular.
4	D	CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.
5	A	Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.
6	C	Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.
7	E	Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.
8	B	Bloquear distintas etapas de la replicación viral.
9	D	Leucemia/linfoma de células T del adulto.
10	C	Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.
11	A	Nucleocápside excéntrica dentro del virión maduro
12	A	Insertar el ADN proviral en el genoma de la célula hospedadora
13	C	Ausencia de correceptores como CCR5 o CXCR4 en sus linfocitos
14	A	Se sintetiza ARN viral a partir del ADN mediante ARN polimerasa celular
15	B	El recuento de linfocitos T CD4 y la presencia de infecciones oportunistas
16	B	CD4 entre 200 y 499 y porcentaje entre 14% y 28%
17	B	Dentro de las primeras 2 horas del suceso
18	D	Sarcoma de Kaposi
19	C	Porque posee alta sensibilidad pero especificidad limitada, pudiendo dar falsos positivos
20	B	Disminuir el riesgo de resistencias y mutaciones virales
21	B	Replicación viral persistente pero lenta, con descenso gradual de CD4
22	B	Disminuye drásticamente hasta ser casi inexistente
23	A	Linfocitos T, macrófagos y células dendríticas
24	C	Permitir que el virión salga adquiriendo envoltura lipídica
25	C	Provoca pérdida o disminución severa de la respuesta
26	A	Digerir polipéptidos largos para formar proteínas y enzimas funcionales
27	B	Que la replicación masiva termina destruyendo la célula infectada
28	C	Diarrea asociada a Salmonella, Shigella y Campylobacter
29	B	Controlan la progresión, pero requieren activación por CD4
30	A	Persona que vive con VIH
31	A	Infección de microglía y neuronas por VIH o infecciones oportunistas

12. Generalidades, huéspedes y prevención

N°	Letra	Respuesta correcta
1	E	Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.
2	B	Desarrollo larvario o reproducción asexual.
3	D	Mantiene el parásito disponible para transmisión.
4	A	En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.
5	C	Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.

Nº	Letra	Respuesta correcta
6	E	Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.
7	B	Examen coproparasitológico seriado.
8	D	Unicelulares.
9	C	Letrinas, calzado y lavado de manos.
10	A	Indirecto o heteroxeno.

13. Paludismo

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	B	Hembras de Anopheles.
2	D	Higado.
3	A	Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.
4	C	Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.
5	E	Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.
6	B	Antígenos parasitarios.
7	D	P. vivax y P. ovale.
8	C	Transplacentaria o transfusional.
9	A	Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.
10	E	Control vectorial y protección contra picaduras.

14. Trypanosoma

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	D	Trypanosoma cruzi.
2	A	Heces de triatomino contaminan piel lesionada o mucosas.
3	C	Amastigote.
4	E	Tripomastigotes.
5	B	Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.
6	D	Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.
7	C	Megaesofago o megacolon.
8	A	Serología con pruebas diferentes.
9	E	Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.
10	B	T. brucei y mosca tsetse.

15. Toxoplasma gondii

Nº	Letra	Respuesta correcta
1	A	Felino.
2	C	Trofozoíto/taquizoíto.
3	E	Fase crónica y transmisión por carne.
4	B	Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.
5	D	La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.
6	C	Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.
7	A	Encefalitis con lesiones cerebrales.
8	E	IgM, IgG y avididad de IgG.
9	B	Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.
10	D	Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.

16. Leishmania

N°	Letra	Respuesta correcta
1	C	Promastigote metaciclico.
2	E	Amastigote en macrofagos.
3	B	Flebotomo.
4	D	Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.
5	C	Perro.
6	A	Destruccion de mucosas naso-orofaringeas.
7	E	Amastigotes en material de lesion o medula.
8	B	Aumenta mortalidad y dificulta manejo.
9	D	Control del vector, reservorios y proteccion contra picaduras.
10	A	Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.

17. Protozoarios intestinales y urogenitales

N°	Letra	Respuesta correcta
1	E	Resistente e infecciosa.
2	B	Heces recientes.
3	D	Entamoeba histolytica invasiva.
4	C	Duodeno y yeyuno proximal.
5	A	Giardiasis.
6	E	No tiene fase quística y se transmite sexualmente.
7	B	Cerdos y cuadros disintéricos.
8	D	Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.
9	A	Busqueda de quistes/trofozoitos o antigenos en heces.
10	C	Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.

18. Nematodos intestinales

N°	Letra	Respuesta correcta
1	B	Huevo embrionado ingerido.
2	D	Migracion larvaria pulmonar con eosinofilia.
3	C	Existe alta carga de vermes adultos.
4	A	Prolapso rectal y anemia.
5	E	Cinta adhesiva perianal matinal.
6	B	Oxiuriasis.
7	D	Autoinfección e hiperinfección.
8	A	Penetracion cutanea de larvas filariformes.
9	C	Perdida crónica de sangre intestinal.
10	E	Larva migrans visceral u ocular.

19. Cestodos

N°	Letra	Respuesta correcta
1	D	Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.
2	C	Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica.
3	A	Carne bovina con cisticercos.
4	E	Huevos de Taenia solium.

N°	Letra	Respuesta correcta
5	B	Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.
6	D	Puede completar ciclo directo y autoinfectar.
7	A	Ingestion accidental de pulgas infectadas.
8	C	Huesped intermediario accidental.
9	E	Adultos intestinales.
10	B	Imagenes y serología segun localizacion.

20. Trematodos

N°	Letra	Respuesta correcta
1	C	Caracoles del genero Lymnaea.
2	A	Metacercaria en vegetacion acuática.
3	E	Vias biliares.
4	B	Heces.
5	D	Migracion hepática, dolor y eosinofilia.
6	A	Penetra activamente la piel.
7	C	Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.
8	E	Compromiso intestinal-hepatico y hipertension portal.
9	B	Hematuria y riesgo de cáncer vesical.
10	D	Grandes y operculados.

21. Artrópodos de importancia médica

N°	Letra	Respuesta correcta
1	A	Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.
2	E	Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.
3	B	Arrastre pasivo sin multiplicacion del agente.
4	D	Trypanosoma cruzi.
5	A	Leishmania.
6	C	Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.
7	E	Piojos.
8	B	Vectores biologicos de varios agentes.
9	D	Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.
10	C	Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.

22. Importancia médica de serpientes

N°	Letra	Respuesta correcta
1	E	Bothrops.
2	B	Incluye especies capaces de accidentes severos.
3	D	Dolor, edema, sangrado local y alteracion de coagulación.
4	A	Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.
5	C	Cuadro neurotoxico.
6	E	Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.
7	B	Suero antiofidico indicado segun tipo y gravedad.
8	D	Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local.
9	C	Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.

N°	Letra	Respuesta correcta
10	A	Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.